
Odontopediatria

Conteúdo completo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Princípios Gerais em Odontopediatria	3
02 Dentição Decídua, Permanente, Cronologia e Alterações	4
03 Cárie Dentária em Odontopediatria	5
04 Flúor: Usos, Formas, Indicações e Riscos	6
05 Anestesia em Odontopediatria	7
06 Endodontia em Dentes Decíduos	8

01

CONTEÚDO COMPLETO

Princípios Gerais em Odontopediatria

PONTOS-CHAVE

Campo operatório:

Manter materiais fora da vista da criança, esconder agulha, diminuir ansiedade.

Educação em saúde: escovação supervisionada, orientação de dieta, motivação dos pais.

Fluorose: monitorar exposição ao flúor em fase crítica (20–30 meses).

Prevenção: aplicação tópica de flúor em alto risco, dentifrícios fluoretados, selantes quando necessário.

Objetivo central da odontopediatria:

Manter a saúde e integridade dos dentes decíduos até sua esfoliação fisiológica.

Garantir espaço adequado e ambiente saudável para a erupção da dentição permanente.

Promover saúde, prevenir cárie e doenças periodontais, controlar comportamento e proporcionar atendimento seguro e positivo.



ANOTAÇÕES

02

CONTEÚDO COMPLETO

Dentição Decídua, Permanente, Cronologia e Alterações

PONTOS-CHAVE

Dentes decíduos:

Incisivos → coroas pequenas, raízes ovais, esmalte fino (coloração branco-azulada).

Caninos → coroas bojudas, raízes elípticas e volumosas.

Molares → coroas menores, com bossa cervical vestibular evidente; não existem pré-molares decíduos.

Cronologia erupção decídua (média):

8 m – incisivo central inferior.

10 m – incisivo central superior.

11–13 m – incisivos laterais.

16–17 m – primeiros molares.

20–22 m – caninos.

28–30 m – segundos molares

Cronologia erupção permanente:

Início: 6 anos (primeiros molares + incisivo central inferior).

Últimos: terceiros molares (20 anos).

Período transitório:

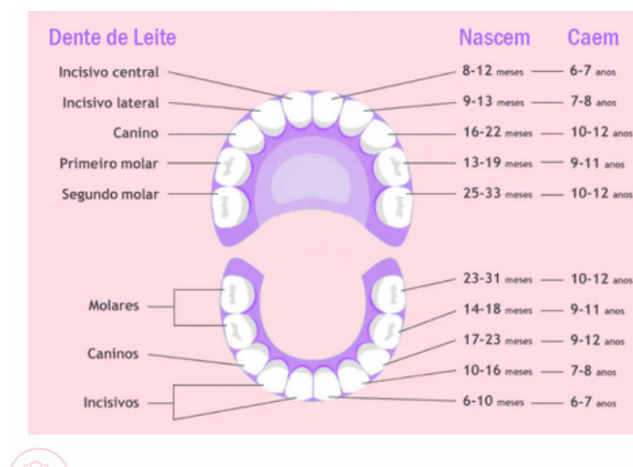
1º período (6–8 anos) → troca de incisivos.

Inclui a “fase do patinho feio”: incisivos superiores vestibularizados, eixos divergentes, overjet acentuado, diastemas fisiológicos que se fecham com erupção dos caninos

Alterações comuns:

Anquilose: fusão osso-raiz, impedindo esfoliação espontânea.

Alterações de cronologia → atrasos podem indicar distúrbios locais ou sistêmicos.



ANOTAÇÕES

03

CONTEÚDO COMPLETO

Cárie Dentária em Odontopediatria

PONTOS-CHAVE

Definição: doença multifatorial resultante do desequilíbrio entre desmineralização e remineralização. O processo patológico inicia-se quando há queda do pH (<5,5), favorecendo a perda mineral.

Etiologia:

Primários: hospedeiro (estrutura dentária, saliva), dieta (consumo frequente de açúcares), tempo (frequência de exposição), microbiota (*Streptococcus mutans*, *Lactobacillus*).

Secundários: fatores comportamentais, educacionais, socioeconômicos e culturais.

Lesões x doença: a cárie é a doença; a cavidade é o sinal clínico.

Diagnóstico: inspeção visual + tátil com sonda OMS. Utiliza-se o ICDAS para padronização:

0 – hígido.

A – inicial (mancha branca rugosa, opaca).

B – moderado (microcavitação, descontinuidade de esmalte, sombra em dentina).

C – severo (cavitação com exposição dentinária).

Lesão ativa: opaca, rugosa, porosa, associada a gengivite adjacente.

Lesão inativa: lisa, polida, escura, aspecto seco e vítreo (remineralizada).

Controle e prevenção: uso racional de flúor, educação em saúde, redução da frequência de açúcar



ANOTAÇÕES

04

CONTEÚDO COMPLETO

Flúor: Usos, Formas, Indicações e Riscos

PONTOS-CHAVE

Meios de uso:

água fluoretada, dentifrícios, soluções (enxaguatórios), géis, vernizes, mousses, materiais restauradores.

Flúor verniz (NaF 5% = 22.600 ppm):

Vantagens: liberação prolongada, aplicação rápida, ideal em alto risco de cárie.

Sequência: profilaxia → isolamento relativo → aplicação por quadrantes → orientações pós (não comer por 1h, dieta pastosa 12h, escovar após 12h).

Flúor gel (FFA 1,23% = 12.300 ppm): aplicado em moldeiras ou pincel. Mais custo, menos efetivo que verniz.

Uso doméstico: dentifrícios fluoretados (>1000 ppm F⁻).

Até 3 anos: grão de arroz.

3 anos: grão de ervilha.

Escovação supervisionada até 7 anos.

Toxicidade:

Aguda: ingestão em excesso (≥ 5 mg/kg). Sintomas → náusea, vômito. Tratamento: leite, antiácido, acompanhamento médico.

Crônica: fluorose. Período crítico → 20–30 meses (formação incisivos centrais superiores).

Comparação: dentifrício fluoretado diário é o método mais racional, custo-efetivo e eficaz



ANOTAÇÕES

05

CONTEÚDO COMPLETO

Anestesia em Odontopediatria

PONTOS-CHAVE

Princípios:

linguagem adaptada; evitar termos negativos. Usar expressões como “se sentir incômodo, levante a mão”.

Posição paciente-operador:

Maxila → 150°.

Mandíbula → 110°.

Operador com mão apoiada e altura correta.

Anestésicos tipo amida: lidocaína, prilocaína, mepivacaína, articaína, bupivacaína.

Cálculo pediátrico:

Lidocaína 2% → máx. 4,4 mg/kg (até 7 tubetes em 60 kg).

Articaína 4% → máx. 7 mg/kg.

Anestesia tópica: preferir pomada/gel; evitar spray (risco anestesia faringe/glote).

Técnicas:

Infiltrativa: dentes superiores e anteriores inferiores.

Interpapilar/interseptal: antes da anestesia palatina.

Regional pterigomandibular: bloqueio do alveolar inferior (associado ao lingual e bucal).

Complicações possíveis: alergia, superdosagem, trismo. Sempre considerar peso, idade e histórico clínico



ANOTAÇÕES

06

CONTEÚDO COMPLETO

Endodontia em Dentes Decíduos

PONTOS-CHAVE

Particularidades anatômicas:

Câmara pulpar ampla.

Esmalte/dentina finos.

Cornos pulpares proeminentes.

Rizólise fisiológica (bisel apical).

Tratamentos conservadores:

Capeamento indireto → remoção de dentina infectada, manutenção da afetada, material biocompatível para evitar exposição.

Pulpotomia → remoção da polpa coronária mantendo radicular; indicada em exposição acidental.

Tratamento radical:

Pulpectomia.

Indicações: necrose pulpar, sintomatologia dolorosa, lesão periapical sem envolvimento da cripta do permanente.

Contraindicações: rizólise avançada (>2/3), rompimento da cripta, perfuração do assoalho, perda óssea extensa, impossibilidade de restauração.

Pulpectomia passo a passo:

Radiografia diagnóstica.

Anestesia + isolamento absoluto.

Acesso (cíngulo em anteriores, fosseta central em molares).

Odontometria (recuar 1 mm).

Preparo químico-mecânico:

Limas manuais, irrigação (hipoclorito 0,5–1% + Endo-PTC).

Irrigação final com EDTA.

Secagem.

Obturação com Pasta Guedes-Pinto (iodofórmio + paramonoclorofenol + rifocort).

Selamento com guta-percha para evitar contato com material restaurador.

Restauração definitiva e RX final

**ANOTAÇÕES**

Odontopediatria Teórico

Aula - Teórico

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Odontopediatria Teórico	3
02 Odontopediatria Teórico (parte 2)	7
03 Odontopediatria Teórico (parte 3)	14
04 Odontopediatria Teórico (parte 4)	18
05 Odontopediatria Teórico (parte 5)	22
06 Odontopediatria Teórico (parte 6)	27
07 Odontopediatria Teórico (parte 7)	30
08 Odontopediatria Teórico (parte 8)	33
09 Odontopediatria Teórico (parte 9)	37
10 Odontopediatria Teórico (parte 10)	40
11 Odontopediatria Teórico (parte 11)	44
12 Odontopediatria Teórico (parte 12)	47
13 Odontopediatria Teórico (parte 13)	50
14 Odontopediatria Teórico (parte 14)	54

01

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico

Aula ministrada pela Dra. Profa. Amanda Nussi, na Universidade Cidade de São Paulo. Utilizei o livro de Odontopediatria do Antônio Carlos Guedes-Pinto.

Odontogênese: ela se inicia durante a gestação, entre a 7ª e a 10ª semana de vida intra-uterina. No 4º meses de vida intra-uterina, inicia-se a dentinogênese. Isso significa que o bebê nasce com o mínimo as coroas dos dentes decíduos formadas, porém ainda não erupcionadas.

HÁ CASOS EM QUE O BEBÊ JÁ NASCE COM DENTE, CHAMA-SE DENTE NATAL, ELES NORMALMENTE NÃO ESTÃO APOIADOS NO OSSO, ESTÃO SOLTOS NA GENGIVA. DEVE-SE ANALISAR SE ELE É UM DENTE SUPRANUMERÁRIO OU NÃO. CASO NÃO SEJA SUPRANUMERÁRIO, AVALIA- SE FORMAS DE MANTÊ-LO NA BOCA PARA NÃO PREJUDICAR SUA DENTIÇÃO.

Para saber mais, leia o resumo Histologia e Embriologia Oral 😊

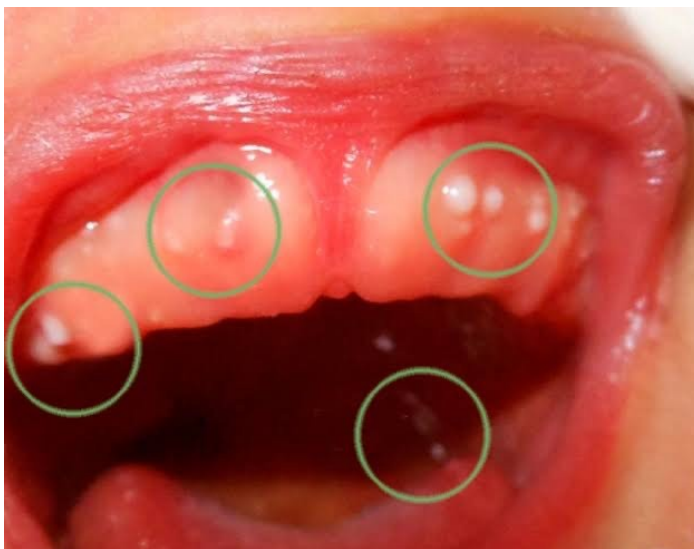
Importância dos dentes decíduos

PONTOS-CHAVE

- Atuar no desenvolvimento dos maxilares;
- Na mastigação, fonação, oclusão e estética;
- Como guia de erupção para os dentes permanentes irromperem na posição correta.

No nascimento...

- Mandíbula em posição mais retraída com relação à maxila;
- Presença de Rodetes Gengivais;



Mandíbula realiza pequenos movimentos, devido pouco desenvolvimento da cavidade articular e do côndilo.

Na amamentação...

O efeito de sucção do bebê, estimulará a função muscular, aumentando e estimulando o crescimento dos maxilares e mandíbula. Além de ser importante por conta da fisiologia da amamentação, pela posição inversa da língua que o bebê deve fazer para mamar.

O 1º surto de crescimento da maxila e da mandíbula, ocorre na época da irrupção dos dentes decíduos.

6 a 30 meses...

Maxilares crescem;

Mandíbula tem maior velocidade de crescimento e se aproxima da maxila;

Incisivos inferiores erupcionam;

12 a 16 meses: 1° molar decíduo erupciona e temos o primeiro ganho de dimensão vertical;

24 a 30 meses: 2° molar decíduo erupciona e estabiliza a dimensão vertical;

Até 36 meses: dentição decídua completa.

3 a 5 anos: período de relativa estabilidade.

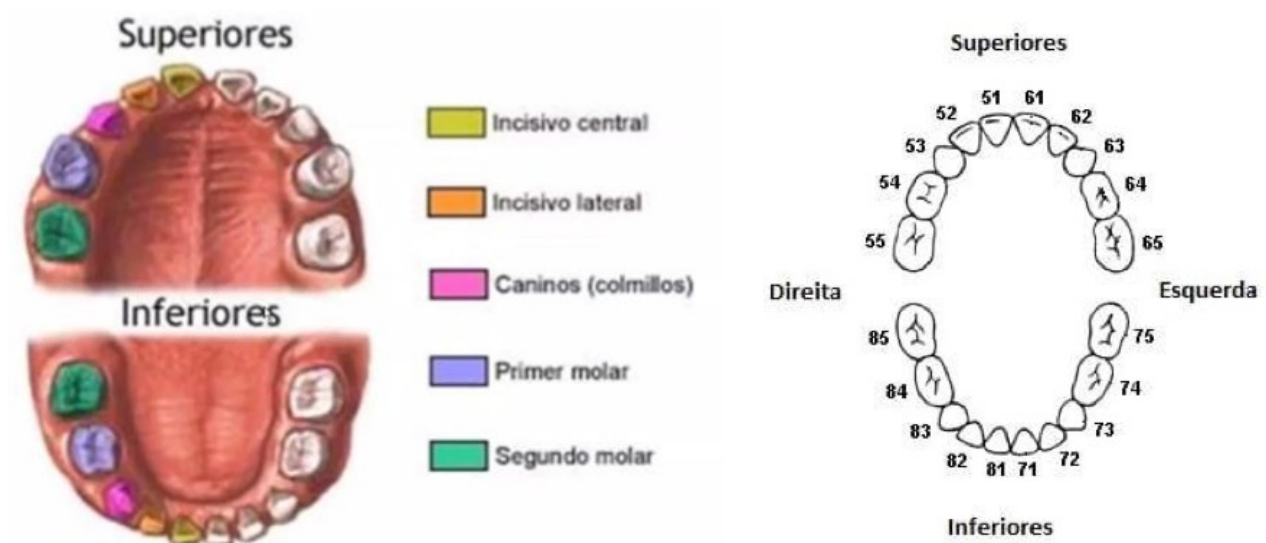


Aos 5 anos, as coroas dos permanentes já estão sendo formadas (vistas radiograficamente). Enquanto a raiz dos permanentes estão sendo formadas, as raízes dos decíduos estão sendo reabsorvidas.

Uma criança com dentição decídua completa tem o total de 20 dentes. A permanente tem um total de 32. Ou seja, temos 3 dentes extras, o 1, 2 e 3M.

A dentição mista inicia aos 6 anos, ou seja, a dentição decídua erupciona até os 5 anos. Mas para isso ↑ precisamos ter a sequência de erupção dos dentes.

O 1M e o 2M vão dar origem aos PM permanentes. Os dentes permanentes que vão dar início ao processo de erupção dos dentes. OBS: O 2M decíduo vai ser muito parecido com o 1M permanente.



Maxila	Lado direito
51	IC decíduo
52	IL decíduo
53	Canino decíduo
54	1M decíduo
55	2M decíduo

Maxila	Lado esquerdo
61	IC decíduo
62	IL decíduo
63	Canino decíduo
64	1M decíduo
65	2M decíduo

Mandíbula	Lado esquerdo
71	IC decíduo
72	IL decíduo
73	Canino decíduo
74	1M decíduo
75	2M decíduo

Mandíbula	Lado direito
81	IC decíduo
82	IL decíduo
83	Canino decíduo
84	1M decíduo
85	2M decíduo

Sequência favorável de erupção dos dentes decíduos

Incisivo Central → Incisivo Lateral → 1M → Canino → 2M.

O 1M vem primeiro que o canino na maxila!!

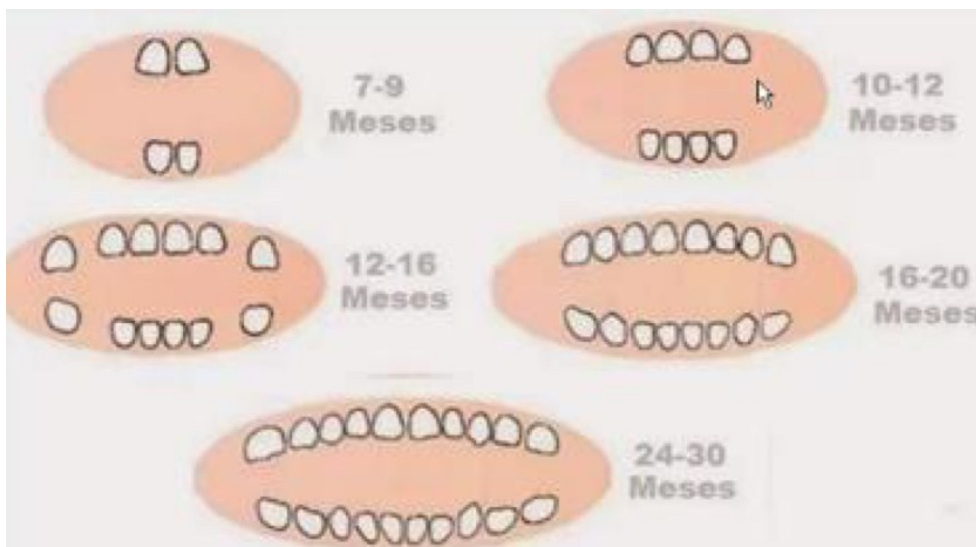
Cronologia de erupção dos dentes decíduos em meses

	Mandíbula	Maxila
IC	6 meses	7 1/2 meses
IL	7 meses	9 meses
Canino	16 meses	18 meses
1M	12 meses	14 meses
2M	20 meses	24 meses

Cronologia = tempo/período/data.

Os 9 meses da criança é um período em que posso ter uma alteração

nessa cronologia, lembrando, não é uma regra, cada criança, é uma criança. É para o CD odontopediatra se preocupar quando a criança tiver 1 ano e não tiver erupcionado nenhum dente, e então posso pedir uma radiografia periapical. É importante lembrar que não podemos pedir panorâmica para crianças abaixo de 5 anos.



Em menos essa cronologia pode acontecer mais rápido, pois elas tendem a ter um desenvolvimento acelerado.

Os molares permanentes nascem atrás dos molares decíduos, enquanto esses são substituídos pelos pré-molares permanentes.

Obs: deve-se tomar cuidado durante a irrupção do 1M, pois muitas vezes a criança não higieniza corretamente ali, além disso, dentes em irrupção tem menor grau de mineralização, por isso quando aparecem na cavidade, podem já estar cariados.

Vista Vestíbulo-Lingual

Implantação vertical dos dentes na base óssea, assim os incisivos e molares estão no mesmo plano, sem Curva de Spee. Ou seja, dentes decíduos não tem essa curvatura.

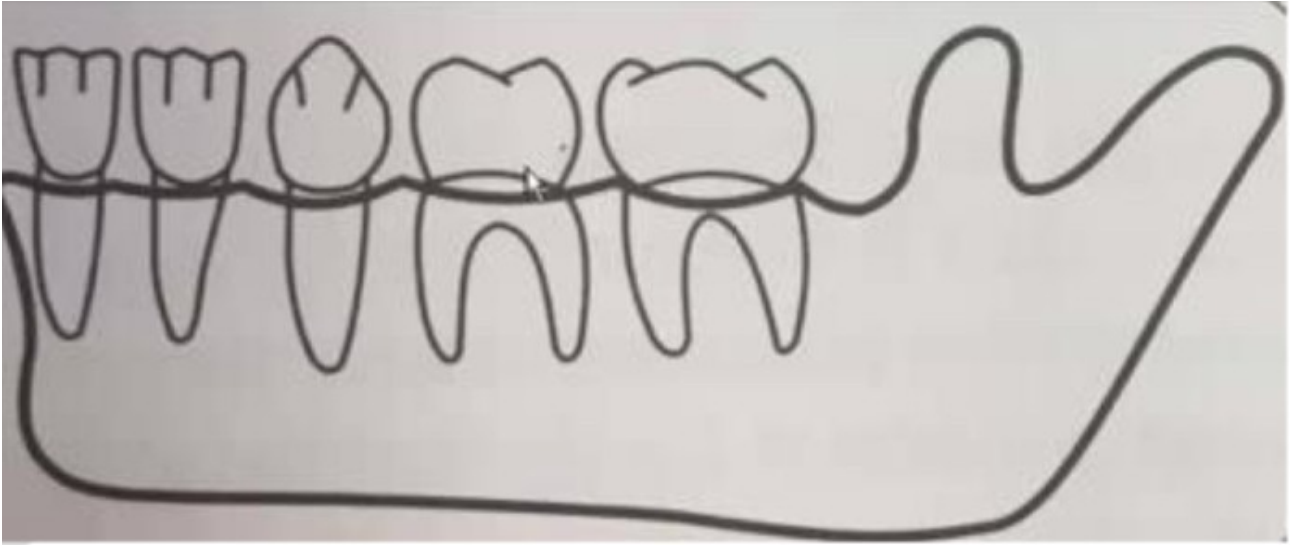
A ATM está na altura do plano oclusal e paralela a este plano.

ANOTAÇÕES

02

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 2)



Podemos ou não ter a presença de **diastemas fisiológicos**.

Tendo 3 tipos de ARCOS DE BAUME:

1. Arco tipo 1 de Baume;



Tenho espaço entre os dentes. É ótimo para trabalhar movimentos quando a criança está com 5/6 anos de idade, e usamos os aparelhos ortopédicos. Presença de diastemas na região anterior em ambas arcadas. Favorável ao bom posicionamento de dentes permanentes anteriores.

2. Arco tipo 2 de Baume;



Não tem nenhum tipo de espaço. Ausência de diastemas na região anterior em ambas arcadas. Tendência a apinhamento na região anterior e cáries proximais.

3. Tipo Misto;



Arco tipo 1 superior e tipo 2 inferior ou tipo 2 no superior e 1 no inferior. Característico de uso de chupeta.

Espaços Primatas

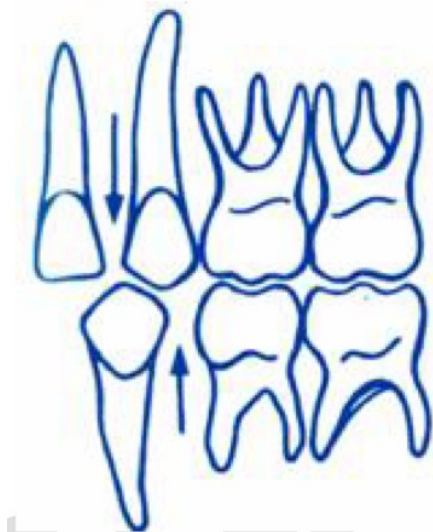
São diastemas fisiológicos = espaços, presentes na dentição decídua, independentemente do tipo de arco. Nem sempre existem.

PONTOS-CHAVE

Arco superior: localizado entre Incisivos Laterais e Caninos;

Arco inferior: localizado entre Caninos e Primeiros Molares.

Chave canina



Aos 5 anos → visualizamos o central, lateral e canino, 1M e 2M. E a presença dos permanentes em estágios diferentes = Estágios de Nolla.



Relação Molar ou Plano Terminal

- Relação distal em plano;
- Degrau mesial para mandíbula;
- Degrau distal para mandíbula;

Ou seja, vamos ter uma oclusão, e ter uma classificação.

Relação distal em plano

O 1º molar permanente erupciona em topo, com a substituição de Molares Decíduos por Pré-molares, pode se estabelecer em Classe I.



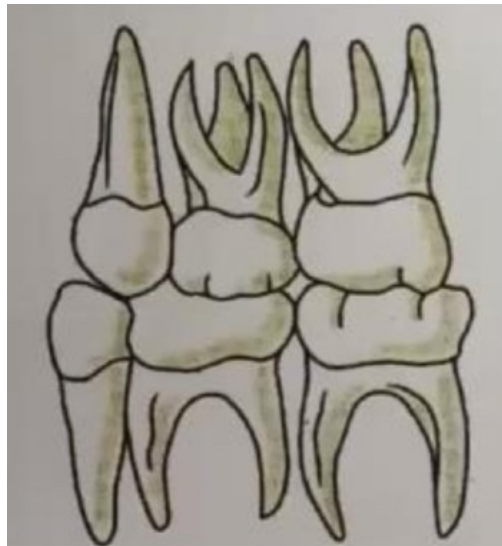
Degrau mesial para mandíbula



O 1º molar permanente tende a erupcionar em Classe I ou Classe III, devido a pressão exercida pelo mesmo na distal do 2º molar decíduo.

Degrau distal para mandíbula

O 1º molar permanente tende a erupcionar em Classe II, sendo isto um prenúncio de Malocclusão.



Chave molar

Classe I;



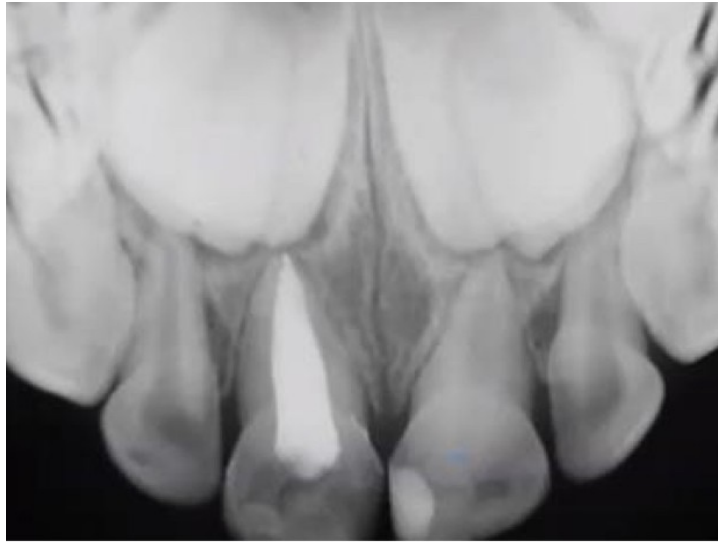
CLASSIFICAÇÃO
ANGLE

OdontoUP

Classe II;

Classe III;

Osso alveolar na dentição decídua



Apresenta o trabeculado ósseo mais frouxo e menos calcificado, quando comparado à dentição permanente.

Observações: O comprimento da raiz do dente decíduo (IC) = 14 a 18mm. É importante sabermos para fazer uma endodontia, extração...para entender que fase que este dente se encontra. O comprimento de raiz vai diminuindo até ele esfoliar.

Entre o nascimento do permanente e a raiz do decíduo, tem um halo radiopaco, que se chama CRIPTA, é um osso que protege o permanente, que vai reabsorvendo aos poucos. Quando ela reabsorve precocemente não é bom, porque é uma proteção do dente, além de ter uma conexão direta com o decíduo (perigoso quando fazemos uma endodontia, porque pode atingir o permanente).

Algumas das características dos dentes decíduos

Os dentes decíduos são menores que os permanentes, em todas as suas dimensões. Além das raízes também serem menores, mais delgadas e mais claras.

Dentes decíduos apresentam coloração branco-leitosa. Ele é mais branco porque tem menos deposição de dentina, ou seja, é menos espesso internamente. Então se tenho uma lesão de cárie em um dente decíduo, vai ser acometido mais facilmente.

Molares decíduos são dispostos em ordem crescente (o 1M é menor do que o 2M, tanto no superior quanto no inferior);

Coroas mais amplas no sentido mesio-distal, em comparação com a dimensão cérvico-oclusal.

Constrição cervical acentuada (é um dente “acinturado”).

Raízes longas e afiliadas com relação às dimensões da coroa.

Raízes de molares divergentes para apical;

A câmara pulpar de um **dente decíduo é bem volumosa**, sendo que o corno mesial sempre vai ser mais alto e mais perto, então quando fazemos um acesso endodôntico, precisamos começar pela mesial, porque é mais fácil. Além de ter menos estrutura dentária para proteger a polpa. O canal radicular é muito delgado. Só vou fazer tratamento endodôntico se o dente permanente estiver envolto da cripta. Ou seja, quando formos fazer uma restauração precisamos ter muito cuidado.

Além de ser **menor a espessura de esmalte e dentina**. Além do esmalte dos decíduos é mais permeável e mais facilmente de ser desgastado.

A profundidade do esmalte é maior e mais fino, sendo que a espessura de esmalte dos decíduos está em torno de 0,5 a 1,0mm.

Proximidade teto/assoalho (alto risco de atingir o assoalho com a broca, provocando uma perfuração).

Raízes sofrem reabsorção *fisiológica* = rizólise, o que chamamos de reabsorção 360°. **Reabsorção parcial em anteriores:** quando a criança apresenta pouca área, pouco espaço, o dente permanente irrompe mesmo assim e o dente decíduo ficará lá, sem ser reabsorvido totalmente.

Raízes sofrem reabsorção *patológica*: reabsorções que fogem do aspecto

ANOTAÇÕES

03

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 3)

fisiológico, do aspecto natural de reabsorção (rizólise) do dente decíduo.

PONTOS-CHAVE

Nos dentes decíduos recém-irrompidos, as cúspides tendem a ter pontas mais afiladas.
Sulcos mais pronunciados.
Canais pulpopерiodontais (lesão de furca).
Canais secundários e acessórios.
Reabsorção irregular.

O periodonto é formado pelo osso alveolar, pelo cimento e pelo ligamento periodontal, bem como pelo sulco gengival. São estruturas responsáveis pela proteção e sustentação do dente no interior do alvéolo (osso). No processo pré-eruptivo ocorre o crescimento concêntrico do germe dentário no interior de seu folículo, em direção a cavidade oral. Externamente o osso alveolar estará sendo desenvolvido, formando uma cripta óssea. O osso do processo alveolar circunda o folículo dentário constituindo a cripta óssea.

Os **dentes decíduos começam a se formar na 6ª a 8ª semana de vida uterina**, ou seja, quando a mãe está grávida a criança já tem dentes.

Os **dentes permanentes começam a se formar na 20ª semana**.

E então, no 6ª mês de vida intra-uterina todos os dentes decíduos já iniciaram a sua calcificação.

Aos 03 anos de idade a criança deverá estar com 20 dentes decíduos, ou seja, devem estar TODOS em boca.

Se a mãe é usuária de tabaco, ou drogas, pode afetar na calcificação e formação dos dentes.

Teremos um período que chamamos de maturação, a calcificação inicia aos 6 meses de vida uterina, e depois que o dente irrompe temos mais dois anos para finalizar a calcificação do esmalte.

O bebê prematuro pode ter alteração na SEQUÊNCIA, mas NUNCA na CRONOLOGIA.

Caso clínico: uma criança de 2 anos de idade aparece no seu consultório e só tem 4 dentes (centrais inferiores e superiores) na boca, é normal? Os centrais podem sair em uma fase de 6 a 12 meses. Os laterais saem com 9 a 13 meses. Ou seja, a criança está em uma janela que posso classificar como normal!.

Erupção

Pré-eruptiva (intra-óssea): tem início com a diferenciação do germe dentário e término com a formação completa da coroa dentária.

Pré-funcional ou eruptiva (intra e extraóssea): inicia com a coroa formada e início da rizogênese, e termina quando o dente atinge o plano oclusal.

Pós-eruptiva: tem início quando o dente entra em oclusão com o antagonista e termina com a perda ou remoção do elemento dental.

Rizogênese: formação da raiz; Rizólise: reabsorção da raiz;

A cronologia de erupção corresponde à data que o dente irrompe na cavidade bucal.

A erupção é um processo fisiológico, podendo estar acompanhada por desordens sistêmicas, sequência de erupção é a ordem na qual os dentes irrompem na boca.

Uma sequência de erupção correta é mais importante que a cronologia. Pois a cronologia pode variar de criança para criança, porém o acompanhamento deve ser da sequência para observar alguma anormalidade.

Cronologia e erupção dos dentes decíduos

1. A partir dos **6 meses**: IC inferiores;
2. A partir dos **7 meses**: IL inferiores e Centrais superiores;
3. A partir do **9 mês**: IL superiores;
4. A partir do **12ª mês** (entre o 12ª. 14ª): 1M inferior;
5. A partir do **16ª mês**: 1M inferior e Canino inferior;
6. A partir do **18ª mês**: caninos superiores;
7. A partir do **20º mês**: 2M inferior;
8. A partir do **24ª mês**: 2M inferior.

Resumindo a sequência:

Incisivos;
1Ms;
Caninos;
2Ms;

3 anos = 36 meses. Metade de 1 ano de vida e até os 3 anos a criança tem que ter os 20 dentes.

Cronologia e erupção dos dentes permanentes

Dentição Permanente		
Erupção	Dentes Superiores	Dentes Inferiores
Incisivos Centrais	7-8 anos	6-7 anos
Incisivos Laterais	8-9 anos	7-8 anos
Caninos	11-12 anos	9-11 anos
1º Pré-Molar	10-11 anos	9-11 anos
2º Pré-Molar	10-12 anos	10-12 anos
1º Molar *	6-7 anos	6-7 anos
2º Molar	12-13 anos	11-12 anos
3º Molar	17-30 anos	17-30 anos

Fatores que influenciam na erupção:

De ordem geral:

Decíduos: de origem genética (erupção precoce ou tardia).

Permanentes (influência do meio mais intensa): diferença entre os sexos (erupção + precoce no sexo feminino) e diferenças sociais (afetam a nutrição que podem retardar a erupção).

Fatores de ordem local:

Permanentes: dentes supranumerários, odontomas, dilaceração radicular, perda precoce do decíduo, falta de espaço, retenção prolongada do decíduo, anquilose, fibrosamento da mucosa gengival, entre outros.

Os pais acham que o primeiro molar é um dente decíduo deixando de dar o devido cuidado/higiene. Pelo fato deles não substituírem o primeiro molar decíduo. (lembrando que os substitutos dos primeiros molares decíduos são os

pré-molares).

Estágios de Nolla



Fases e estágios de Nolla

0 = ausência de cripta; **1** = cripta formada; A cripta óssea vou encontrar na radiografia como um halo radiopaco.

2 = mineralização inicial; Começo a ver o germe dentário.

3 = 1/3 de coroa formada; **4** = 2/3 de mineralização da coroa; **5** = coroa quase completa; **6** = coroa totalmente mineralizada; Nessa fase está se iniciando a movimentação do teto da cripta e os movimentos de erupção dos permanentes.

7 = 1/3 de raiz formada; Rompimento total da cripta.

8 = 2/3 de raiz formada; Passando pela crista alveolar.

9 = raiz quase formada e ápice aberto; Entre a fase 8 e 9 temos a fase eruptiva. Rompe a margem gengival.

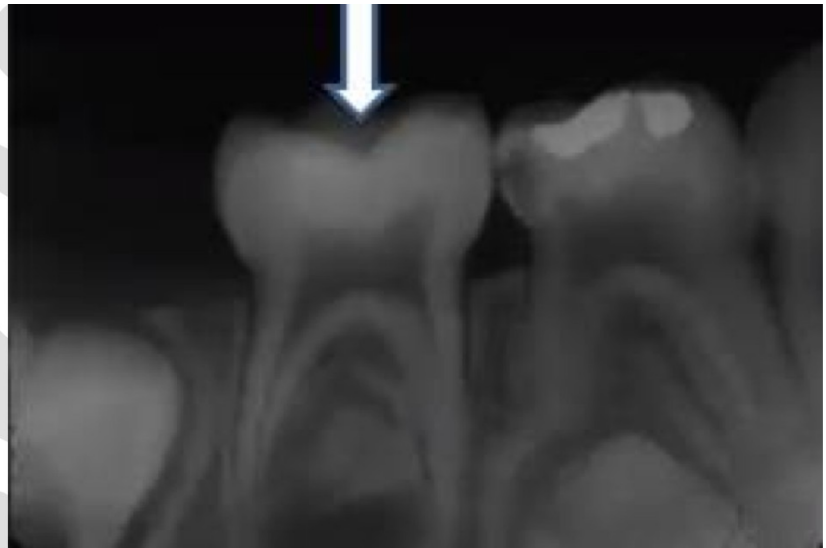
10 = raiz formada e ápice fechado;

Teremos apenas dentes permanentes com 12 a 13 anos.

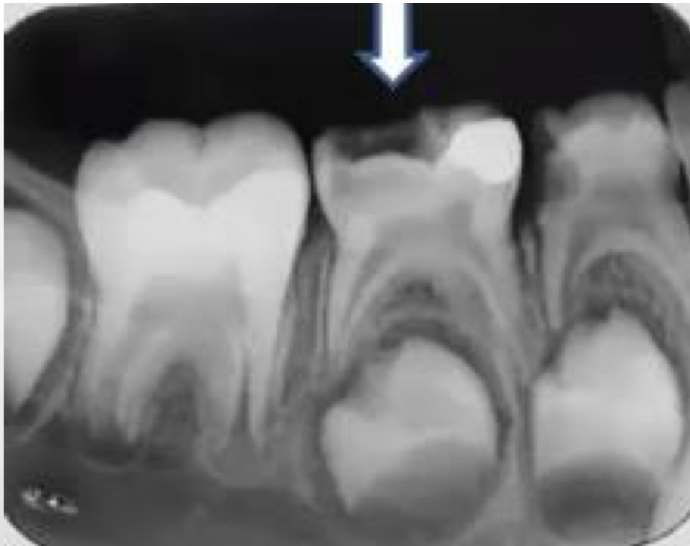
O ciclo biológico do dente decíduo é curto → assim ele envelhece muito mais rápido, diminuindo seu potencial de respostas frente a estímulos.

Ciclo vital dos dentes decíduos

Jovem; Dente decíduo desde a sua formação até entrar em contato com o antagonista. Ainda não iniciou o processo de reabsorção (neném).



Maduro; Dente em fase de estabilidade. Já se formou, mas ainda não está se reabsorvendo. Alteração das características da polpa.



ANOTAÇÕES

04

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 4)

PONTOS-CHAVE

Senil; Já está no processo de reabsorção.



O dente decíduo não tem ápice fechado devido a rizólise → quando as raízes sofrem reabsorção fisiológica.

Anatomia dos dentes decíduos

Para mais informações, leia o pdf de perguntas e respostas. 😊

Os **molares decíduos** são dispostos em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Além de que os M decíduos são iguais aos M permanentes.

IC Superior

Coroa: achatada no sentido vestibulolingual, com um rebordo acentuado no colo.

Face vestibular trapezoidal, com a base maior voltada para a borda incisiva.

Faces proximais: triangulares e com os ângulos arredondados.

Raiz: 2x mais longa que a coroa, normalmente única, cônico, com ligeiro achatamento no sentido vestibulolingual;

O comprimento da sua raiz varia entre 16-17mm antes da rizólise.

IC Inferior

Coroa: trapézio alongado, com base maior na borda incisal.

Face vestibular plana.

Raiz é mais longa, mais afilada e mais estreita que no incisivo central.

Cavidade pulpar segue o contorno do dente e o canal radicular único - formato oval - sem demarcação definida.

O comprimento da sua raiz varia entre 09-11mm antes da rizólise.

IL Superior

Menor que o central em todas as dimensões.

Face vestibular é muito convexa.

Desvio para vestibular e para distal no seu terço apical.

As faces proximais são triangulares.

Cavidade pulpar segue o formato externo do dente.

O comprimento da sua raiz varia entre 14-16mm antes da rizólise.

IL Inferior

Dimensões maiores que os incisivos centrais inferiores, são menos simétricos.

Cíngulo mais desenvolvido e ligeiramente desviado para o lado. Raiz é mais longa, mais afilada e mais estreita que no central-desvio para vestibular e para distal no terço apical.

Cavidade pulpar segue o contorno do dente e o canal radicular único - formato oval - sem demarcação definida.

O comprimento da sua raiz varia entre 10-12mm antes da rizólise.

Canino Inferior Face vestibular convexa. Terço cervical presença de túber. Borda mesial da cúspide é menor que a distal. Raiz 2x o comprimento da coroa, um pouco achatada no sentido mesiodistal: mais curta que a raiz do canino superior. O comprimento da sua raiz varia entre 11-13mm antes da rizólise.

Canino Superior Mais robustos que os incisivos. **Coroa:** constrição na cervical em relação a sua largura mesiodistal. Raiz robusta e levemente inclinada para vestibular no terço apical. **Cavidade pulpar:** forma externa do dente com pouca demarcação. O comprimento da sua raiz varia entre 12-14mm antes da rizólise. 1M Superior Coroa cúbica irregular - mais larga do que alta-grande estrangulamento no colo. Mais atípico dos molares decíduos (lembra um pré-molar superior). Crista oblíqua. **Raízes:** 3 (duas vestibulares e outra lingual - mais longa e curvada, divergentes entre si).

Câmara pulpar: ampla formato externo da coroa, com três ou quatro cornos pulpares.

O comprimento da sua raiz varia entre 8-10mm antes da rizólise.

1M Inferior

Não lembra nenhum outro dente (aparenta a união de dois pré-molares).

Face vestibular: lado distal mais curto.

Crista transversa une as duas cúspides mesiais.

Duas raízes mesial e distal - planas, largas e bem separadas, muito achatadas e divergentes.

Câmara pulpar: uma câmara, acompanha o formato externo da coroa, com quatro cornos.

O comprimento da sua raiz varia entre 10-15mm antes da rizólise.

2M Superior

Assemelha-se ao primeiro molar superior permanente — isomorfismo.

Possui duas cúspides vestibulares e duas linguais.

Crista oblíqua proeminente.

Raízes: três (duas vestibulares e uma lingual).

Cavidade pulpar: câmara pulpar ampla com três canais radiculares e quatro cornos pulpares, sendo o mesiovestibular o mais proeminente.

O comprimento da sua raiz varia entre 16,5-18,5mm antes da rizólise.

2M Inferior

Lembra o primeiro molar permanente — isomorfismo.

Cisco cúspides: sendo elas mesiovestibular, distovestibular e distal com duas linguais.

Raízes duas vezes maiores que a coroa.

Duas raízes (mesial e distal) longas, delgadas e separadas.

Camara pulpar segue o contorno externo do dente, com cinco cornos pulpares.

EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO RADICULAR, TEMOS: MÉCIO- VESTIBULAR DE 15-17 mm, MESIO- LINGUAL DE 11-16mm, DISTO- VESTIBULAR DE 13-16 MM E DISTO- LINGUAL DE 12-16 mm.

Radiologia em Odontopediatria

Ferramenta mais utilizada como auxiliar no diagnóstico, preservação e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente.

É um exame complementar, portanto, sua interpretação deve ser considerada em conjunto com anamnese, exame clínico e outros dados, nunca isolado.

Determinar o momento ideal para realizar o exame radiográfico, frequência e número de raios-X, evitando fazer o exame em momento inadequado.

Sempre realizar um preparo psicológico do paciente infantil para o exame radiográfico. Conversar com a criança sempre mostrando o que será feito (*técnica do mostrar, falar e fazer*).

Após anamnese e exame clínico, avaliar o histórico médico, sinais e sintomas → Necessidade ou quando as informações oferecidas serão de grande utilidade.

Uma informação importante é que os filmes para odontopediatria devem ser ultra-rápidos. Além de quem segura o filme radiográfico caso seja feita a técnica da bisettriz, ou qualquer outra técnica é os pais, então devemos usar as técnicas de segurança neles também, o avental plumbífero e o colar cervical. E sempre perguntar se a mãe está grávida, ou alguma acompanhante mulher.



Existem filmes radiográficos de adultos e os infantis. Ou seja, quando for dente permanente uso o filme de adulto, e quando for dentição decídua o filme infantil, lembrando que também depende da idade e o tamanho da cavidade bucal desta criança.

Técnicas radiográficas aplicadas na pediatria

Periapical

Mostram as relações anatômicas entre os dentes decíduos e os sucessores permanentes em desenvolvimento, do ponto de vista intra-ósseo.

Vou ver o dente decíduo e o germe do dente permanente.

Diagnóstico e controle da terapia pulpar.

ANOTAÇÕES

05

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 5)

Observação da câmara e do conduto radicular.



Técnica modificada para região anterior inferior



Técnica modificada para região anterior superior

Método da bisettriz: a *vantagem* desta técnica é não utilizar o posicionador, e a *desvantagem* é visualizar o plano da bisettriz.

Nesta idade as crianças podem apresentar dificuldade motora para manter o filme em posição com a pressão digital e podem não conseguir se adaptar ao posicionador.

Método do paralelismo: a *vantagem* é a fácil execução, é um exame padronizado e menor grau de distorção. Já a *desvantagem* é que precisa de maior tempo de exposição (corre risco da criança se movimentar), desconforto, custo do posicionador.

Técnica Periapical Modificada: A adaptação é

feita para a radiografia periapical pela técnica da bisettriz, normalmente em idade pré-escolar (dentes decíduos).

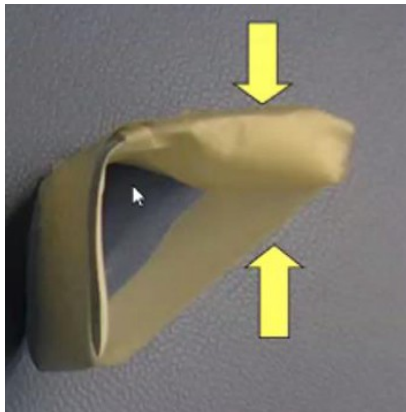
A criança não precisa segurar o filme com a mão. O filme será posicionado e a criança deverá morder a película, mantendo-a em posição para o exame.

Periapical em região anterior:

O filme é posicionado perpendicularmente em relação ao eixo sagital mediano e apreendido através da mordida, com a parte sensível do filme voltado para a arcada a ser radiografada. Semelhante a técnica oclusal. A apreensão do filme pode ser feita diretamente através da oclusão, com o mesmo filme radiográficos utilizado em adultos.

É importante nas idades entre 5 e 7 anos, para diagnóstico da presença de dentes supra-numerários.

Periapical em região posterior:



Técnica modificada para região posterior superior

Filme periapical de adulto dobrado ao meio com rolete de algodão preso em uma das metades.

Após dobrar o filme ao meio, mantê-lo dobrado com auxílio de fita crepe. O paciente morde o filme, mantendo-o paralelo ao longo eixo do dente.

A **partir de 6 anos, em uma radiografia periapical**, a própria criança segura o filme na maxila (polegar) e na mandíbula (indicador) para a técnica da bisettriz ou podemos usar a técnica do paralelismo, com auxílio de um posicionador.

ATENÇÃO: na fase dos 5-7 anos, é um período de troca dos incisivos e há muita alteração no número de dentes supranumerários e/ou agenesia.

Técnica de Clark:

Essa técnica radiográfica é conhecida como técnica do deslocamento horizontal do tubo, sendo desenvolvida para determinar a posição no sentido vestibulo-palatino ou vestibulo-lingual de dentes retidos, corpos estranhos e para dissociação de condutos radiculares. Além de ajudar na localização de um supranumerário.

Interproximal ou Bite-Wing

Diagnóstico de lesões de cárie na região interproximal.

Indicada para:

PONTOS-CHAVE

Diagnosticar possíveis alterações da crista alveolar.

Adaptação de restaurações e lesões de cárie em dentes posteriores.

Profundidade de lesões de cárie oclusal.

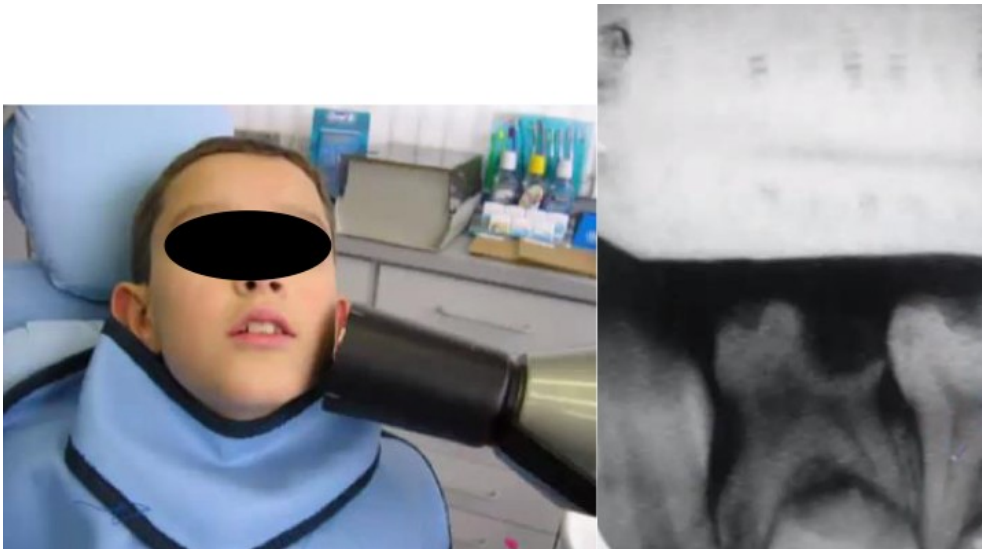
Acompanhamento de controle de lesões de esmalte interproximais e/ou lesões sem rupturas ósseas interradiculares.

Obs: as cáries oclusais só aparecem na radiografia se tiver profundidade de pelo menos 0,5mm em dentina (junção amelo-dentinária).

A criança deve estar posicionada com a linha tragus-comissura paralela ao plano horizontal e o plano sagital mediano perpendicular ao solo.

A angulação horizontal paralela à superfície interproximal dos dentes a serem radiografados.

É indicado também a utilização de posicionadores próprios para posicionar filme e a aleta de mordida Aleta no →



Técnica modificada para região posterior inferior



filme com fita crepe.

Usar um filme periapical padrão dobrado em seu menor eixo.

Diário alimentar

Fornecer informações completas sobre o padrão alimentar do paciente.

O responsável anota, no período de 3 ou 7 dias, o que foi ingerido nas refeições principais e entre elas, inclusive medicamentos;

Anotar o que ingeriu, quando e quanto.

ANOTAÇÕES

06

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 6)

Dar para o paciente e para os pais um aconselhamento dietético, que tem como função diminuir a ingestão de alimentos cariogênicos, buscando alternativas adequadas de acordo com a idade e necessidade nutricional individual.

A dieta recebe influências do núcleo familiar, do estado emocional, da religião e do nível sócio-econômico cultural.

O que avaliar no diário alimentar?

PONTOS-CHAVE

Frequência; Vamos avaliar o número de refeições principais (RP) e lanches (L), além de verificar o horário.

Alimentos ingeridos nas RP são menos cariogênicos do que os ingeridos entre elas, nos L. Por isso, o ideal é inserir os alimentos com sacarose nas refeições principais, como na sobremesa.

Consistência e adesividade; A forma como esses alimentos são ingeridos (cru, cozido, assado, líquido, sólido) —> isso está relacionado com o tempo de permanência do alimento em boca.

Alimentos que contém açúcar e são sólidos/pegajosos são mais difíceis de serem removidos, ou seja, ficam mais tempo em contato com a superfície dental.

Alimentos duros e fibrosos estimulam a produção de saliva.

Qualidade do tipo de alimento; Por exemplo, alimentos pegajosos que tem a textura firme —> queijos, semestres, pipoca —> aumenta o fluxo salivar.

Quantidade;

Açúcar oculto; Salgadinhos, cereais, xaropes, uva-passa —> o açúcar neste caso funciona como um conservante e texturizante.

Tempo de permanência na cavidade bucal; Carboidratos de frutas, vegetais e bebidas: 5 minutos ☹

Produtos açucarados e sólidos: 30 a 40 min ☹ (reduzem o pH = 4)

Alimentos com açúcar e farinha refinada (bolachas recheadas): 2h ☹.

Medicamentos; Ajuda a deixar o medicamento mais “docinho”, além de ajudar na conservação.

Estes medicamentos causam a queda do pH semelhante a soluções de sacarose.

Hábitos familiares;

Relação açúcar-afeto (por exemplo, quando uma criança recebe doces em troca de algo, ou simplesmente por amor, carinho, cuidado).

Análise do diário alimentar

Anotar ao lado dos horários de refeições quais são principais e quais são lanches. Refeições realizadas em intervalos inferiores a 20 minutos são agrupadas.

Circular em vermelho a **sacarose**.

Anotar o número de refeições principais e lanches na tabela do prontuário.

Anotar a frequência de ingestão de sacarose.

Avaliar a consistência da sacarose e qualidade da dieta.

5ª feira		6ª feira		Sábado	
8:00 	Leite/ Nescau pão c/ manteiga	7:30 	Suco laranja c/ açúcar e 2 torradas/ manteiga	8:30 	Leite c/ Nescau e 3 torradas c/ manteiga
10:00 	2 bolachas recheadas	7:45 	½ pacote de salgadinho	10:20 	2 balas Toffee
13:00 	Arroz, feijão, bife, suco laranja c/ açúcar e pudim	13:00 	Arroz/ carne / couve- flor e suco limão c/ açúcar/ goiabada	13:40 	Macarrão / suco caju c/ açúcar e gelatina de morango
16:00 	1 maçã	15:30 	2 caquis	16:30 	Bolo de chocolate
19:00 	Sopa / torta de frango e água	19:15 	Ovo frito/ arroz / purê de batata/ água e sorvete	20:00 	Arroz / frango / farofa e suco de uva c/ açúcar
21:00 	2 bombons	21:20 	Pipoca/ água	21:35 	1 banana

Plano de tratamento

Fase Preparatória

Atuar nos fatores de risco para o controle da doença.

Fase preventiva: Etapa para evitar que surjam novas lesões, controlando os fatores de risco.

Procedimentos:

Evidenciação de placa;

Polimento coronário;

Limpeza profissional;

Aplicação tópica de flúor;

Selantes de fossas e fissuras;

Orientação e motivação de higiene bucal; Tipo de escova; Dentífrício com flúor; Técnica de escovação de acordo com a faixa etária - FONES; Stillman e Stillman modificada; Posição de Starkey (onde a mãe está na cadeira e segura o filho); Orientação do uso do fio dental — técnica e frequência.

Orientação da dieta baseado no diário alimentar.

Remineralização de manchas brancas ativas.

Cariostáticos.

Adequação do meio: Remoção de focos infecciosos para controle da progressão das lesões e paralisação desse processo.

Como por exemplo:

Restabelecimento do equilíbrio ecológico;

Diminuição do risco e/ou atividade de cárie;

Preparo da boca para receber o tratamento restaurador.

Remoção parcial de tecido cariado + restauração com ionômero de vidro;

Terapia pulpar;

Exodontias;

Remoção total ou parcial do tecido cariado + CIV ou IRM (Óxido de Zinco e Eugenol).

Finalidades: Condicionamento; Alívio da dor; Remoção de nichos e focos; Drenagem de abscessos; Diminui atividade de cárie; Aumento do pH e fluxo salivar; Diminui nº de microrganismos; Permitir higiene oral; Favorecer

maturação pós eruptiva; Reestabelecer mastigação.

Profilaxia profissional:

Placa e película não são uma barreira à captação de flúor no esmalte, portanto não é necessário profilaxia para aplicar flúor. Pacientes que apresentam maior risco de desenvolver cárie e/ou doença periodontal devem ter retornos mais frequentes. Instruir o cuidador e a criança ou adolescente em técnicas adequadas a higiene bucal. Remover a placa dentária, mancha extrínseca e cálculo depositados nos dentes. Introduzir procedimentos dentários à criança pequena e paciente apreensivo.

Pós adequação do meio:

Reavaliação dos hábitos: alimentares (novo diário), higiene bucal (novo mapa).

ANOTAÇÕES

07

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 7)

Quando houve modificações de alteração de risco e de atividade de cárie, entro na fase restauradora.

Fase Restauradora

Ela entra após fazermos a modificação da atividade/risco.

PONTOS-CHAVE

Restabelecer Dimensão Vertical;
Restaurações / próteses;
Ortodontia preventiva

Objetivos: Recuperação da forma, função e estética dos dentes.

Tipos de resina:

Resina bulk fill flow: Polimeriza em maior quantidade, não preciso fazer por incrementos.

Resina composta convencional: Por incrementos.

Fase de Manutenção

Lesões inativas em esmalte e dentina → acompanhamento ou restauração.

Estratégias para tratamento de lesões de cárie ativas: Lesões iniciais Lesões moderadas Lesões avançadas

Lesões iniciais = mancha branca → esmalte não está cavitado, temos que: Escovação dental supervisionada sempre com flúor (tem dente na boca, é com flúor);

Verniz fluoretado OU Infiltrante resinoso (usamos nas regiões proximais);

Diamino fluoreto de prata = cariostático.

Lesões moderadas → somente esmalte cavitado OU dentina (sem abertura ampla).

Esmalte cavitado Diamino fluoretado de prata = cariostático. Selante de fóssulas e fissuras na oclusal, com excessão de palatina onde tem cingulo.

Dentina Selante de fóssulas e fissuras na oclusal, com excessão de palatina onde tem cingulo. Tratamento restaurador atraumático (ART - usamos CIV com cureta).

Lesões avançadas → dentina cavitada Diamino fluoretado de prata = cariostático. Tratamento restaurador atraumático (ART - usamos CIV com cureta). Técnica de Hall → coroa metálica.

Porém independente da situação vamos fazer escovação com dentifrício fluoretado e controle de dieta.

Ou seja, nesta fase de manutenção, vamos reavaliar dieta, fazer mapa de higiene, limpeza profissional, checagem de qual tratamento seguir, raio X final... E no retorno desse paciente vamos pedir novos exames e raio X de controle. O tempo de retorno será de acordo com a forma que o paciente chegou na primeira consulta.

Dentro da fase preventiva temos:

Evidenciação de placa e profilaxia

Evidenciação



É uma substância que permitem a visualização da placa bacteriana.

Tintura vegetal

Ajuda a prevenir cáries e gengivite, através da visualização da placa bacteriana não removida, antes que torne-se uma doença instalada.

Vamos utilizar em pacientes (especialmente em crianças) para melhorar a higienização bucal, garantindo a possibilidade de remover toda a placa bacteriana. Ele é interessante devido ao fato de contribuir para a escovação dos dentes mostrando os locais que precisam ser higienizados.

Técnica gotas - PASSO A PASSO:

Espalhe algumas gotas do evidenciador sobre os dentes utilizando uma bolinha de algodão bem pequena ou um microbrush;

Aguarde alguns segundos até ué surja o efeito desejado;

Enxágue a boca com água para remover todo o excesso do produto;

Após remover o excesso é só escovar os dentes da maneira correta (escova de Robson nas faces oclusais, e taça de

borracha nas faces livres), dando uma atenção para as áreas que ficaram mais manchadas.

Também temos uma técnica que usamos as pastilhas (o pior), o evidenciador em bochecho (muito mais rápido).

Profilaxia

Procedimento profissional no qual remove a placa bacteriana presente na superfície dentária.

Fazemos a profilaxia a cada 6 meses, e em pediatria o indicado é não fazer na primeira consulta se for uma criança difícil. Usada para prevenção de gengivites, cáries... Quando houver necessidade de promover a remoção de placa bacteriana, assim como cálculos e de manchas superficiais, fazemos a raspagem e/ou polimento.

Técnica da Profilaxia - PASSO A PASSO:

Tartarectomia Fazemos a raspagem para a remoção de tártaros com aparelho de ultrassom, ou até mesmo curetas especializadas. Este aparelho de ultrassom emite vibrações ultrassônicas que facilitam a remoção do cálculo.

Escovação e polimento Polimento realizado com caneta de baixa rotação e escovas ou taças de borracha em associação com abrasivos. Em superfícies dentárias lisas correspondentes a faces vestibular e lingual/palatina, o material mais indicado para polimento é a taça de borracha. Já em superfícies e fissuras — oclusal dos dentes posteriores —, indica-se a utilização de escovas de Robinson.

Aplicação de flúor Flúor é aplicado para remineralização do esmalte dentário e proteção superior contra cáries.

Flúor Tópico (gel neutro e acidulado)

A Política Nacional de Saúde Bucal tem como eixos orientadores ações de promoção e proteção à saúde, incluindo a educação em saúde, higiene bucal supervisionada, fluoretação das águas, aplicações tópicas de flúor e recuperação e reabilitação da saúde bucal.

O flúor é um mineral encontrado em várias fontes, incluindo a água potável e produtos dentários. Ele fortalece o esmalte dos dentes, **prevenindo a cárie e promovendo uma boa saúde bucal**. A aplicação tópica de flúor (ATF) é um procedimento preventivo que tem como objetivo fortalecer os dentes que apresentam médio e alto risco de cárie. Porém o flúor pode ter efeitos deletérios ao esmalte (fluorose), e efeitos benéficos ao esmalte (prevenir cáries). A fluorose acontece na infância e “ataca” apenas a dentição permanente. Por exemplo, a pasta Tandy que era muito utilizada na infância. Ou seja, o flúor aumenta a prevalência de fluorose.

Ou seja, temos que fazer o **uso racional do flúor** onde iremos maximizar a exposição tópica durante toda a vida e minimizando a absorção sistêmica durante o período em que o dente está se desenvolvendo.

A utilização do flúor sendo seu uso isolado não impede o desenvolvimento de cárie, mesmo sendo um auxiliar na prevenção.

Iremos usar o flúor e indicar de acordo com o risco e a idade, e optar sempre pelo método ou associação de métodos.

Utilização de fluoretos em Odontologia

Sistêmico

Tópico

Sistêmico

Ao ser ingerido atingiria os dentes em formação, onde se incorporaria aos dentes trazendo um efeito pré-eruptivo.

Água fluoretada;

Uma das principais medidas de saúde coletiva.

Força do método: isoladamente reduz 50 a 60% a prevalência após 11 anos de utilização contínua.

Concentração ótima: 0,6 a 0,8 pp,.F.

Sal de cozinha;

Medicamentos;

Tópico

Dentífricos;

O problema não está na concentração do flúor e sim na quantidade que está sendo usada. Usamos “meio grão de arroz” para crianças em até 2 anos → “1 grão de arroz” para crianças de 3-6 anos → “1 grão de ervilha” para crianças acima de 6 anos. Em bebês até 4 meses não utilizamos dentífrico e nem escova, após 4 meses até aparecer dente usar uma gaze sem dentífrico, apenas para higienizar 2x ao dia.

Considerado atualmente como maior responsável pelo declínio da cárie.

ANOTAÇÕES

08

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 8)

PONTOS-CHAVE

Controle de placa + uso de flúor.

Importante para controle tanto de cárie de esmalte como de dentina.

Concentração entre 1000-1100 ppm F.

Bochechos;

Extremamente relevante até pouco tempo.

Na prática, é importante em saúde coletiva para grupos de risco.

Uso individual: Sol. de NaF a 0,05% - diário.

Uso coletivo: Sol. de NaF a 0,2% -semanal.



10 ml / 1min / antes de dormir

Aplicação profissional;

Para compensar as deficiências do paciente.

Em saúde coletiva para grupos de alto risco.

Uma única aplicação tem pouca eficiência.

Formas: solução, gel, vernizes, espuma.

Recomendado: cárie ativa / após erupção dental / deficiência salivar / pós cirurgia periodontal / após reabilitações / problemas comportamentais / PNE / pacientes ortodônticos.

Materiais odontológico;

Ou seja, para o desenvolvimento da cárie temos agentes que ajudam como o açúcar e para a sua prevenção temos que auxiliar o paciente na sua disciplina; além da placa, onde nos CD's e o paciente em casa deve fazer a desorganização do mesmo. E nos CD's e o paciente pode usar o flúor para prevenir a cárie.

Ação do flúor:

Manutenção constante na cavidade bucal, ou seja, não é aplicar uma vez e o paciente está prevenido de cáries;

Interferência no processo DES-RE;

Não interfere na formação de placa e na transformação de açúcares em ácido → diminuir a formação de fluoropatita.

Chamamos este tipo de gel flúor de acidulado porque ele tem ácido fosfórico, utilizado para remover manchas dos dentes e aumentar a adesão ao esmalte dentário. Já o gel neutro é uma forma concentrada de flúor, livre de ácidos. Ele é utilizado como uma medida preventiva para fortalecer o esmalte, reduzir a formação de placa bacteriana e auxiliar na sensibilidade.

Além de ajudar na:

Remineralização dos dentes, repondo minerais essenciais.
Tem uma proteção duradoura.
Um ótimo aliado após profilaxia dental;
Para remoção de manchas devido o ácido presente;
Tratamento de hipoplasia de esmalte;
Pós tratamento ortodôntico; Todos com a função proteger contra cáries.

Quando o paciente volta para fazer uma segunda aplicação? **Depende do risco de cárie!**

Técnica - PASSO A PASSO - Acidulado FFA a 1,23%:

Vantagens: 1. Sabor aceitável; 2. Nenhum manchamento; 3. Aplicação ambos os arcos;

Desvantagens:

1. Pode atacar restaurações de porcelana; 2. Perigoso se deglutido;

Aplicação:

1. Paciente sentado, sugador e isolamento do campo; 2. Secar os dentes; 3. Embeber os dentes por 4 minutos; 4. Expectorar.



A partir de 6 anos.

Profilaxia com pedra pomes e água; Posicionar o paciente em 90°; Isolamento relativo com rolete de algodão e sugador por quadrante; Moldeira: 4 minutos total. É melhor. Por quadrante: 4 min por quadrante = 16 minutos; Secagem com ar;

Aplicação do gel com pincel/cotonete ou até mesmo com as moldeiras. Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante; Remover o excesso do gel com uma gaze; Remover o isolamento relativo; Não enxaguar a boca do paciente; Pedir para o paciente cuspir TUDO várias vezes;

Técnica - PASSO A PASSO - Fluoreto de sódio a 2% - solução ou gel:

Vantagens:

1. pH neutro; 2. Sabor agradável; 3. Sem efeito adverso;

Desvantagens:

1. Perigoso se deglutido.

Aplicação:

1. Com cotonete (sol.) ou moldeiras (gel).

São necessárias 4 aplicações, com no máximo 7 dias de intervalo, o que aumenta o custo.

Tempo de exposição de flúor, exemplo "tempo de 1 minuto". Temos que avaliar o tempo do fabricante, porém o tempo máximo é de 4 minutos.

O **flúor gel acidulado** necessita de menor frequência de aplicação.

Vantagens e desvantagens de usar os géis com a moldeira

Vantagens: aplicação em ambas as arcadas.

Desvantagens: não é indicado para crianças menores de 5 anos // maior probabilidade de ingestão.

Cuidados com o gel fluoretado

- O paciente não deve estar em jejum;
- Cadeira em posição de 90°;
- Usar sugador;
- Não enxaguar;
- O paciente deve cuspir várias vezes;
- Não comer nem beber nada por 30 minutos;

Selante Ionomérico

Ionomérico vem de Ionômero de Vidro, sendo que temos duas formas de apresentação: pó + líquido (mais utilizada) e a fotoativada

Já o cimento de ionômero de vidro é modificado por resina (tipo III ou IV), que é indicado para forramentos ou base e selamento de cicatrículas e fissuras.

Os **benefícios** de seu uso são a liberação periódica de flúor, controle do biofilme, resistência e longevidade (10 anos no mínimo).

Quando usar:

- Alto risco de cárie;
- Indivíduos não cooperativos;
- Dentes que não estão em oclusão;
- Fóssulas e fissuras profundas;
- Pacientes especiais.

Protocolo de aplicação - passo a passo:

Duas formas de aplicação: 1. Convencional 2. Modificada

Modificada:

- Profilaxia;
- Isolamento relativo;
- Aplicação do sistema adesivo (tem alguns que não precisa);
- Fotopolimerização;
- Aplicação do Selante Ionomérico;
- Verificação da ausência de bolhas;
- Fotopolimerização;
- Ajuste oclusal.

A **indicação** de usar o selante Ionomérico é no período de erupção e maturação dentária (2-3 anos após sair em boca) → dentes permanentes.

Aplicamos em fôssulas e fissuras nos dentes posteriores, e nos anteriores na palatina, porém quando há a presença de cingulo, não aplicamos em vestibular.

Selante Resinoso

Ele tem a capacidade de escoar nas cicatrículas e fissuras, penetrando nas microporosidades do esmalte previamente condicionado, formando projeções de resina conhecidas como tags. *O selante trabalha em extensão, não em profundidade.*

Sobre as fôssulas e fissuras oclusais de dentes susceptíveis ao desenvolvimento de lesões de cárie, o selante uni-se firmemente à estrutura dentária e formando assim, uma camada protetora, adesiva e micromecânica, que impede a retenção de restos alimentares e biofilme dental, isolando a superfície dental de fatores cariogênicos impedindo desta forma a evolução da lesão de cárie.

Quando usar?

Os selantes são recomendados para todas as crianças com alto índice de cárie. Especialmente naqueles dentes posteriores recém erupcionados, pois há maior acúmulo de alimentos e bactérias, por conta de sua morfologia oclusal

ANOTAÇÕES

09

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 9)

complexa, que impede a higienização adequada.

Função preventiva: Prevenir cárie.

Função terapêutica: Controlar a cárie já instalada

Protocolo de aplicação - PASSO A PASSO:

1. Radiografia inicial no elemento dentário. **2.** Profilaxia dental com escova de Robinson, pedra-pomes e água. **3.** Isolamento absoluto dos elementos dentários envolvidos. **4.** Condicionamento ácido, com ácido fosfórico a 37% durante 30 segundos em seguida lavagem com jato de água e secagem com jato de ar por 15s. **5.** Após o condicionamento ácido, o esmalte deverá apresentar-se com um aspecto opaco esbranquiçado livre de qualquer contaminação por fluídos. **6.** Aplicação do selante com uma sonda exploradora em todos os sulcos e fissuras. **7.** Fotopolimerização por 20 segundos. **8.** Após retirar o isolamento absoluto, verificar o ajuste oclusal com papel carbono, se tiver contatos prematuros remover com broca adiamantada ou desgastar com pontas abrasivas. **9.** Orientações aos pais sob acompanhamento clínico e higienização dental. **10.** Radiografia após 6 meses de selamento (acompanhar a evolução da cárie). Vou radiografar o elemento dentário se houver cavitação, se não, NÃO! Usamos a Sonda tipo Ball, ela tem uma bolinha inativa na ponta, isso ajuda a não riscar o esmalte e a ver se há cavidade.

ANTIGAMENTE: Em alguns casos se utiliza a técnica mínimamente invasiva para sulcos e fissuras com alterações cromáticas (cicatriculas escurecidas),

localizadas nos molares emprega-se uma ponta diamantada com limite em forma de ponta de lápis, bastante útil para o desgaste do esmalte e broca esférica lisa carbide 1/4, favorecendo a penetração do selante. *Hoje O MENOS É MAIS, então NÃO utilizamos a broca.*

Flúor Tópico - Verniz

São produtos de alta concentração, indicados para Fluoterapia intensiva, manipulados por profissionais qualificados.

Utilizamos vernizes de 22.600 ppm.

ATENÇÃO INDIVIDUAL
SEM ATIVIDADE DE CÁRIE

Faixa etária	Dentifricio	gel	Verniz	Bochecho diário
0 a 5	Sim	1 aplicação (embrocção) na alta e nas manutenções	1 aplicação na alta e nas manutenções	Não
6 e mais	Sim	1 aplicação na alta e nas manutenções	1 aplicação nos dentes permanentes semi-eruptados	Não

COM ATIVIDADE DE CÁRIE

Faixa etária	Dentifricio	Gel	Verniz	Bochecho diário
0 a 5	Sim	5 a 6 aplicações (embrocção) uma por semana	4 aplicações no ano	Não
6 e mais	Sim	5 a 6 aplicações (escovação) uma por semana	5 a 6 aplicações em manchas brancas ativas e dentes semi-eruptados	Domiciliar

Quando usar?:

PONTOS-CHAVE

Proteção adicional contra cárie em adultos e crianças; A partir do momento em que a criança tem dentes, possui risco de ter cárie.

Pacientes que possuem alto índice de cárie e usam aparelho ortodôntico;

Sensibilidade dentária;

Molares parcialmente erupcionados;

Protocolo de aplicação - PASSO A PASSO:

Considerações:

Sua adesividade permite que o produto seja aplicado apenas nas áreas de maior risco, minimizando uma exposição à alta quantidade de flúor.

Indicado para todo tipo de paciente.

A aplicação é feita em ambiente clínico, com auxílio de pinceis.

Menores de 2 anos: não se recomenda nenhum tipo de solução de flúor, sendo o verniz considerado a melhor indicação.

1. Profilaxia pedra pomes e água; **2.** Isolamento relativo: gaze + sugador; **3.** Secar com jato de ar; **4.** Aplicação com microbrush, ou até mesmo um pincel; **5.** Gotejar água nas superfícies recobertas com verniz para facilitar sua fixação.

Por ele ter alta concentração e liberação lenta, recomenda-se que o paciente fique 2h sem comer e sem beber, e 12h sem alimentos pegajosos e sem nenhum atrito, como por exemplo, não escovar os dentes. Podendo ser usado em todas as idades. Devida a sua alta concentração, o verniz tem coloração amarela, por tanto as vezes mancha os dentes.

O flúor também pode ser aplicado sob os dentes na forma de verniz. Essa forma de aplicação é mais recomendada para pacientes muito jovens que não toleram o uso de moldeiras;

Cariostáticos

É uma substância líquida utilizada para iniciar a continuidade da cárie, e seus principais componentes são: prata + flúor + amônia.

No BR, é comercializado nas concentrações de 10%, 12%, 30% e 38%. O mais indicado é o de 38%, e o melhor é o da SDI de 2 passos (Riva Star ou Riva Star Aqua = sem amônia).

Ou seja, iremos utilizar quando houver cárie em atividade em dentes anteriores ou posteriores, apresentar desafio de manejo comportamental ou médico e lesões de cárie cavitadas, com várias lesões de cárie cavitadas com dificuldade para serem tratadas em uma visita, com lesões de cárie difíceis de tratar, sem acesso ou com dificuldade em acesso a serviços de atendimento odontológico.

Se possível, radiografias devem ser feitas para avaliar a profundidade das lesões, caso seja uma lesão muito profunda não usamos Cariostáticos, pois pode agredir a polpa;

Separados ortodônticos (cáries nas interproximais) podem ser usados para ajudar a obter acesso a lesões;

Não há sinais clínicos de inflamação pulpar ou relatos de dor não provocada/ espontânea;

Lesões de cárie cavitadas que não estão invadindo a polpa;

Lesões de cárie cavitadas em qualquer superfície, desde que sejam acessíveis com um pincel para aplicação.

Aplicações adicionais podem ser realizadas em consultas de retorno, com base na cor e dureza da lesão ou evidência de progressão da lesão. As lesões de cárie podem ser restauradas após o tratamento. Quando as lesões não são restauradas após a terapia, a reaplicação semestral

mostra aumento da taxa de paralização de cárie quando comparada a uma única aplicação.

Possui baixo custo.

É um produto antiestético, deixa as lesões cariosas enegrecidas. Ou seja, antes da aplicação informar os responsáveis que na região em que o processo da cárie estiver presente, ocorrerá o escurecimento.

Eficácia de 47% a 90% com aplicação única dependendo do tamanho da cavidade e localização do dente.

A paralização ocorre em 48hrs. Porém a sua ação é em até 6 meses. Por isso, deve fazer um retorno de 6 em 6 meses.

Protocolo de aplicação - PASSO A PASSO:

1. Profilaxia com pedra pomes e água; **2.** Remoção da dentina amolecida com cureta; **3.** Lavagem e secagem; **4.** Proteção dos lábios do paciente com vaselina; **5.** Isolamento relativo; **6.** Aplicação do cariostático com bolinha de algodão por 3 minutos. **7.** Após o tratamento com SDF, deverá ser aplicado verniz de fluoreto de sódio em todas as superfícies não tratadas para ajudar a prevenir lesões de cárie.

Obs: **Adequação do meio** = restauração provisória Em dentes decíduos o material de eleição é o **CIV** (ionômero de vidro) → ele é um material restaurador que vai ser indicado de acordo com o que eu preciso, por exemplo tem longevidade e aguenta a carga de um dente decíduo. A técnica do CIV vai ser mais simplificada que a RC, pois ele tolera melhor a umidade. Na adequação do meio podemos usar o **Óxido de Zinco e Eugenol**, ele diminui a sensibilidade, muito bom para

pacientes que possuem uma cavidade muito profunda, ele funciona como um Tratamento Expectante (é um material temporário).

A fase **adequo restauradora** = os determinantes estão sendo controlados. Ou seja, quando o material que eu adequei o meio está bom e não precisa trocar. Caso o paciente ainda tenha lesões de cárie, devemos voltar para a fase de adequação do meio.

ANOTAÇÕES

10

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 10)

Terapia Endodôntica em

Dentes Decíduos

A criança possui **fases de desenvolvimento**, como: físico, intelectual e social. Por isso temos que ter **técnicas de gestão de comportamento**, como:

PONTOS-CHAVE

- Mostrar-falar e fazer;
- Controle de voz;
- Modelagem;
- Reforço positivo;
- Distração;
- Estabilização;
- Sedação medicamentosa;
- Inalação com óxido nitroso;
- Anestesia geral;
- Mão sobre a boca;

Essas técnicas de comportamento não são úteis apenas para realizar uma terapia endodôntica, é válido para todos os procedimentos dentro da odontopediatria.

Então devemos observar:

- Controle do comportamento da criança, minimizar a ansiedade e o medo durante o procedimento.
- Aplicação do anestésico tópico (Benzotop), a velocidade da injeção, local da punção.
- Um dos grandes fatores geradores de ansiedade no tratamento odontológico é a anestesia embora possa parecer contraditório que o recurso utilizado para prevenção da dor seja causador de medo e desconforto.
- Na realidade, o grande determinante da percepção dolorosa em procedimentos odontológicos realizados em crianças é o nível de ansiedade prévia e não a utilização de procedimentos invasivos, tais como a punção para a anestesia local.

Técnicas anestésicas em odontopediatria

Técnica Infiltrativa:

- Agulha curta.
- Penetrar na prega da mucosa vestibular no longo eixo do dente.
- Depositar o anestésico o mais próximo possível do ápice do dente a ser anestesiado.

Técnica Interpapilar:

- Agulha curta.
- Penetrar na papila injetando apenas algumas gotas do anestésico.

Técnica Bloqueio Regional:

- Trabalhar em mais de um dente.

Ex: Nervo Mentoniano.

Técnica Intraligamentar:

Entre o ligamento periodontal. A agulha entra no sulco gengival paralelamente ao longo eixo do dente, atingindo as fibras periodontais, indicado para a complementação anestésica em dentes da mandíbula.

Anestésicos			
	Dosagem máxima mg/kg	Dosagem máxima total/mg	*não pode ser excedida
Lidocaína	4,4	300	
Mepicavaina	4,4	300	
Articaína	7,0	500	
Prilocaina	6,0	400	

DOSES MÁXIMAS RECOMENDADAS											
Droga			Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000			Articaína 4% com epinefrina 1:100.000 ou 1:200.000**			Prilocaina 3% com felipressina 0,03% UI/mL		
Dose máxima mg/tubete			4,4 mg/kg (até 300)*			7mg/kg (até 500)*			6mg/kg (até 400mg)*		
			36			72			54		
Peso (kg)	n° max. de tubetes	mg	Peso (kg)	n° max. de tubetes	mg	Peso (kg)	n° max. de tubetes	mg	Peso (kg)	n° max. de tubetes	mg
10	1	44	10	3/4	70	10	1	60	10	3/4	44
15	1 1/2	66	15	1	105	15	1 1/2	90	15	1	66
20	2	88	20	1 1/2	140	20	2	120	20	1 1/2	88
25	2 1/2	110	25	2	175	25	2 1/2	150	25	2	110
30	3 1/2	132	30	2 1/2	210	30	3	180	30	2	132
35	4	154	35	3	245	35	3 1/2	210	35	2 1/2	154
40	4 1/2	176	40	3 1/2	280	40	4	240	40	3	176

*A dosagem máxima total absoluta de anestésico por consulta não deve ser excedida. Tabela considerada em pacientes ASA I.
 **A Articaína não é indicada para menores de 4 anos, por recomendação do fabricante. Alguns autores consideram a dosagem máxima de 5mg/kg.
 Adaptada de Malamed (2004) In: Massara e Rédua (2014). Colaboração Profa. Dra. Carla Gamba



Para que possamos calcular as doses, precisamos saber o peso da criança.

OBS: Ad-Muc é uma pomada fitoterápica indicada para:

Tratamento das gengivas e mucosa inflamada, em caso de gengivite, irritações bucais.

Contém em sua formulação extrato fluído de camomila, que possui reconhecidas propriedades antiinflamatórias, aftas entre outras inflamações.

Se a polpa está hígida e sofre agressão, temos duas opções de tratamento: 1. Tratamento Conservador (proteção do complexo dentino-pulpar); 2. Tratamento Radical (terapia endodôntica); E após a escolha de tratamento, fazemos a restauração.

Tratamento Conservador

Proteção dentino-pulpar;

Capeamento indireto;

Capeamento direto;

Radicais

- Polpotomia;
- Pulpectomia;
- Penetração desinfetante;

Em resumo:

Lesão de mancha branca ativa (MBA) em esmalte é caracterizada por um esmalte opaco, rugoso e poroso.

Lesão de mancha branca em dentina ativa é caracterizada por um esmalte brilhante branco ou escurecido.

Lesão cavitada em dentina ativa é caracterizada pela presença de tecido amolecido com cor amarelada ou castanho claro, aspecto úmido e opacidade no esmalte adjacente, gerando sensibilidade dolorosa.

Lesão cavitada em dentina inativa, ou seja, com presença de tecido endurecido no fundo da lesão com cor marrom escura ou negra, aspecto seco e brilhante, e opacidade no esmalte adjacente com aspecto inativo. Lesão cavitada ativa que atingiu o órgão pulpar, gerando grande sensibilidade dolorosa.

A **adequação** do meio bucal faz parte da filosofia atual de promoção da saúde que visa não só a vedação de cavidades cariosas, reintegrando os dentes afetados na sua função, como também ao controle da atividade cariogênica.

Apresentando as seguintes etapas: 1. Identificar, remover e/ou controlar os fatores da doença; 2. Fazer o controle da placa bacteriana através de higiene da cavidade bucal e profilaxia profissional; 3. Remover parcialmente o tecido cariado e promover imediato preenchimento da cavidade com Cimento de Óxido de Zinco OU CIV.

A **adequação** é uma fase intermediária entre o estado da cavidade bucal como se apresenta no ato da consulta e o estado final do controle da doença cárie. *É a fase preparatória de completa reintegração da cavidade bucal às condições normais de estética e função.*

Capeamento Pulpar Indireto

Indicação:

- Ausência de exposição pulpar clínica;
- Polpa viva;
- Ausência de dor espontânea;
- Dentes decíduos e permanentes jovens;

Prognóstico:

- Formação de dentina reparativa estimulada.

Fazemos a remoção da dentina infectada, deixando parte da dentina afetada, evitando-se a exposição pulpar = Remoção Seletiva do Tecido Cariado.

Podemos fazer o uso da ART (tratamento restaurador atraumático), ou seja, fazemos o uso de curetas para remoção do tecido cariado. Por exemplo, um bebê. Quando fazemos o ART precisamos anestesiarmos em alguns casos, porque a

dentina que está afetada/infectada dói, devido às terminações nervosas.

DENTINA INFECTADA → consistência mole e amarelada, sendo constituída por uma zona de dentina necrótica e desorganizada.

DENTINA CONTAMINADA → textura parcialmente mantida, semelhante a um “tecido de couro”.

Técnica:

1. Anestesia **2.** Isolamento absoluto **3.** Remoção parcial do tecido cariado **4.** Lavagem com água destilada, soro fisiológico ou detergente para remoção de detritos **5.** Secagem com bolinha de algodão estéril **6.** Selamento com CIV **7.** Acompanhamento clínico e radiográfico aguardando 45 a 60 dias = tratamento expectante

Ou seja, quando fazemos um tratamento de Capeamento Pulpar Indireto, não houve exposição pulpar, então usamos produtos para livrar este dente de um tratamento endodôntico, porém nem sempre vai dar certo, por isso fazemos o Tratamento Expectante, vamos esperar para ver se é só restaurar ou temos que fazer o acesso endodôntico.

Capeamento Pulpar Direto Proteção pulpar

Aplicação de um agente protetor e exposição pulpar, com finalidade de promover o restabelecimento da polpa, mantendo sua vitalidade.

ANOTAÇÕES

11

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 11)

Condições especiais:

PONTOS-CHAVE

Exposição accidental pequena;
Dente isolado, com a cárie removida e sem contaminação por saliva;
Crianças com 3-4 anos;
Ciclo biológico (dente jovem → maduro → senil).

Este capeamento pulpar direto fazemos com Hidróxido de Cálcio PA.

Técnica:

1. Anestesia 2. Isolamento absoluto 3. Remoção do tecido cariado QUANDO HOUVER UMA MICRO EXPOSIÇÃO PULPAR 4. Lavar a área da exposição com água destilada, soro fisiológico ou detergente 5. Secagem com bolinha de algodão estéril 6. Aplicação de hidróxido de cálcio PA 7. Colocação de hidróxido de cálcio pasta 8. Restauração provisória com IRM ou CIV 9. Acompanhamento clínico e radiográfico aguardando 45 a 60 dias tratamento expectante =

ART → restauração definitiva e preventiva.

ADEQUAÇÃO DO MEIO → curativo em massa e provisória.

ART

Foi inicialmente desenvolvido pela necessidade de se encontrar um método de preservação de dentes cariados em pessoas de todas as idades, tanto em países em desenvolvimento quanto em comunidades carentes, no qual os recursos são escassos.

Também está disponível como mais uma opção que o CD tem em seu consultório particular ou serviço público, como por exemplo em bebês com cárie precoce (ECC) e pacientes com necessidades especiais, entre outros. *O ART é um método de remoção do tecido cariado através da escavação da dentina infectada, apenas com instrumentos manuais cortantes, sob isolamento relativo, sem anestesia e após limpeza da cavidade, e seu preenchimento com um material adesivo e liberador de flúor, o CIV.*

Princípios:

Mínima intervenção operatória;
Preservação da estrutura dentária sadia;
Redução da possível necessidade de terapia pulpar ou futura extração;
Não necessita de anestesia local na maioria dos casos;

Contra-indicações:

Lesões de cárie em estágios avançados, com grande comprometimento de estruturas dentárias, bem como dentes com comprometimento pulpar.
Se o paciente apresentar fístulas, abscessos ou outras lesões.

Vantagens:

Baixo custo, técnica simples e de fácil execução.
Técnica conservadora, preventiva e carióstática.

Não utiliza instrumentos rotatórios.

Desvantagens:

Algumas vezes não atende as necessidades curativas do paciente, devido suas limitações - cáries em estágios avançados.

Maior tempo quando comparado com a utilizada de instrumento rotatório.

Cárie oculta, o esmalte está somente com uma pequena abertura. Recomenda-se machados dental, para romper a camada de esmalte socavado.

Risco dos profissionais agirem sem o devido rigor, devido a sua simplicidade da técnica.

Técnica:

Instrumentais necessários: Sonda Pinça Curetas dentinárias de vários tamanhos Machado dental Espátula para inserção Esculpidor Espátula e bloco para manipulação do material

Passo a passo: **1.** Isolamento relativo **2.** Remoção da placa bacteriana com rolos de algodão **3.** Acesso a lesão cariada **4.** Remoção da dentina infectada, amolecida e desmineralizada com curetas dentinárias, fazendo movimento circulares de raspagem **5.** Limpar e secar com bolinha de algodão estéril **6.** Condicionar a cavidade, fôssulas e fissuras adjacentes com ácido poliacrílico de 10 a 15s **7.** Manipulação do CIV **8.** Restaurar a cavidade e preencher fôssulas e fissuras adjacentes, utilizando ponta arredondada da espátula de inserção acomodando o CIV ao redor das margens cavitárias antes de preencher a porção central **9.** Pressão digital (esfregue uma pequena quantidade de vaselina e pressione firme o CIV → deslize a ponta do dedo suavemente da vestibular/lingual e M/D

10. Após alguns segundos retire o dedo com movimento lateral **11.** Ajuste oclusal **12.** Aplicar verniz com flúor **13.** Pedir para o paciente não comer por no mínimo 1h

Formas de conveniência para acesso endodôntico

Pelo processo de DIAFANIZAÇÃO observa-se a anatomia dos canais radiculares.

Molar decíduo superior:

Trapezoidal
3 raízes
3 condutos

Molar decíduo inferior:

Retangular
2 raízes
3 condutos

Anteriores decíduos:

Por palatina ou lingual
Triangular
Inclinação mais vertical (implantação decíduos)

OBS: temos que tomar cuidado na distorção radiográfica, lembrar que a rizólise dos dentes anteriores inicia pela palatina, e nos molares na furca. A anatomia do dente decíduo tem a presença de números canais colaterais, teto e câmara próximos, aumentando o risco de perfuração.

Após a abertura e contorno, temos que remover o teto deixando as paredes lisas → fazemos a odontometria, tomando todo cuidado devido ao estágio de Nolla (ou seja, avaliar bem se o dente é exodontia ou tratamento endodôntico).

Tratamento radical em POLPA VIVA

Indicações:

Dor espontânea; Dentes anteriores: preparo Intra-radicular; Dentes que devam permanecer por mais de 6 meses; Reabsorção interna;

Contra-indicações:

Reabsorção radicular ultrapassando mais de um terço do comprimento da raiz; Falta de integridade da cripta do germe do dente permanente; Impossibilidade de isolamento absoluto. Reabsorção externa;

Obs: em dentes decíduos é contraindicado o uso de cone e guta porque não é reabsorvível.

Passo a passo pulpectomia em dentes decíduos

1. Radiografia **2.** Odontometria Ex: CAD DISTAL: 18mm - 2mm Comprimento de trabalho: 16mm A odontometria deve ser feita em cada raiz.

CAD MESIAL: 15mm - 2mm Comprimento de trabalho: 13mm

3. Bochecho com clorexidina 0,12% **4.** Anestesia **5.** Isolamento absoluto **6.** Assepsia do campo operatório com clorexidina a 2% **7.** Remoção do tecido cariado com curetas **8.** Abertura coronária em alta rotação **9.** Remoção da polpa coronária **10.** Irrigação com Hipoclorito de Sódio 1% ou Clorexidina a 2%

11. Instrumentação dos canais com aspiração e irrigação **12.** Irrigação com EDTA — aguardar 2-3 minutos **13.** Secagem com bolinha de algodão **14.** Secagem com cone de papel

Nesta etapa é possível interromper o procedimento e colocar um curativo de demora seguido de restauração provisória.

No entanto deve-se avaliar o comportamento do paciente, pois na próxima sessão será necessário realizar novamente a sequência de anestesia e isolamento absoluto.

As opções de curativo de demora são: Hidróxido de Cálcio // Paramonoclorofenol Canforado // Formocresol.

Se optar por sessão única, a seguir deve-se realizar a obturação.

Se optar por duas sessões, deve-se iniciar a segunda sessão com anestesia, isolamento, remoção da restauração provisória, irrigação dos canais para remoção do curativo de demora seguida da obturação dos canais.

15. Obturação dos canais: Óxido de Zinco e Eugenol // Pasta Guedes-Pinto // Pasta de Hidróxido de Cálcio // Callen espessada com OZE **16.** Levar o material obturador nos canais com o auxílio da segunda lima utilizada, no comprimento de trabalho. Fazendo sempre movimentos rotatórios anti-horários para que o material permaneça no interior do canal. **17.** Acomodar o material com o auxílio de uma bolinha de algodão. **18.** Obturação da câmara coronária e acomodar o material com o auxílio de bolinha de algodão. **19.** Restauração com material de escolha **20.** Acompanhamento clínico e radiográfico

Polpotomia ou Pulpotomia

ANOTAÇÕES

12

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 12)

Muitos passos são iguais, e muitos são diferentes. Polpotomia: remoção da polpa Pulpectomia: remoção dos canais radiculares, ou seja, a inflamação.

Temos que lembrar do cuidado na hora de alargar o canal.

Quando temos necrose = bactéria → irrigação!!!

A pulpotomia está indicada em casos de dentes que apresentam exposição accidental durante a remoção do tecido cariado e em casos de traumatismo com polpa exposta no máximo por 24 horas.

Na radiografia para diagnóstico deve-se observar ausência de rarefação óssea na região periapical e interradicular; ausência de reabsorção interna da dentina e integridade da lâmina dura, além de ciclo biológico compatível com a possibilidade de regeneração pulpar.

Alterações pulpares reversíveis, onde houve micro exposição pulpar accidental, com o máximo de ausência de contaminação.

1. Organização da mesa clínica 2. Radiografia de diagnóstico 3. Anestesia tópica e local 4. Isolamento absoluto e anti-sepsia com solução de clorexidina 2% 5. Abertura coronária

PONTOS-CHAVE

Remoção de todo tecido cariado com brocas e curetas apropriadas.

Evitar expor a polpa antes da remoção de toda a cárie. 6. Remoção da polpa coronária com cureta grande e afiada

Remoção do teto da câmara pulpar coronária com brocas carbides estéreis novas em baixa rotação.

Corte e remoção da polpa coronária com uma cureta estéril e afiada.

7. Irrigação com soro fisiológico abundante e aspiração 8. Secagem com bolinha de algodão esterelizada

Hemostasia com penso de algodão estéril. 9. Inserção da pasta: HC PA + soro fisiológico 10. Acomodação da pasta com bolinha de algodão estéril

Preenchimento da câmara pulpar com pasta reabsorvível selecionada pelo profissional.

Sobre a pasta acomoda-se e veda-se a câmara pulpar com uma camada de guta percha

Sobre a guta percha realiza-se a restauração provisória do dente 11. Forramento com cimento de CIV

Nas técnicas descritas, temos:

Hidróxido de cálcio PA + soro fisiológico MTA Foromocresol Pasta reabsorvível: PASTA REABSORVÍVEL OU PASTA GUEDES- PINTO.

Pasta Guedes-Pinto (medicação)

Partes iguais de:

Iodofórmio: anti-séptico e estimula neoformação óssea

Rifocort ou Neolon D: antibiótico / corticosteróide

Paramonoclorofenol canforado 3:7: anti-séptico potente

Manipulamos em uma placa de vidro despolida.

Hoje em dia esta pasta não é mais manipulada, devido a sua toxicidade.

Pulpectomia

1. Organização da mesa clínica
2. Radiografia para diagnóstico e determinação do comprimento do dente 3. (CD) e determinação do comprimento de trabalho (CT): $CT = CD - 2 \text{ mm}$

NA ENDO EM DECÍDUOS É -2MM DEVIDO A REABSORÇÃO IRREGULAR DA RIZÓLISE.

4. Anestésias tópica e local
5. Isolamentos absoluto e anti-sepsia com solução de clorexidina 2%
6. Abertura coronária

Remoção do tecido cariado com broca esférica de grande diâmetro e em baixa rotação

Remoção do teto da câmara pulpar: ponta diamantada esférica

Desgaste compensatório: broca Endo-Z ou ponta diamantada 3082

7. Remoção da polpa coronária com cureta afiada
8. Irrigação com *Solução de Milton* (solução de hipoclorito 1%)
9. Visualização da entrada dos canais radiculares com sonda exploradora
10. Extirpação da polpa radicular com lima (tipo Kerr ou Hedstron)
11. Instrumentação dos canais radiculares (molares - Lima Tipo Flexofile 1a série até 35, no máximo. Incisivos - Lima Tipo Kerr 2a série dependendo da amplitude do canal)
12. Irrigação entre as limas com Solução de Milton + Endo PTC e irrigação final com EDTA a 17% por 3 minutos
13. Obturação dos canais
14. Introduzir a pasta nos canais com limas no sentido horário (molares: lima 15 ou 20) ou seringa centrix (incisivos e caninos)
15. Condensar levemente com calcadores
16. Colocar pequena lamínula de guta-percha
17. Preencher a câmara coronária, preferencialmente com CIV
18. Radiografia final
19. Restauração definitiva do elemento dental com material de escolha
20. Controle clínico e radiográfico com 3/6 meses

Quantas limas eu instrumento? Polpa Morta: 3 e irrigação abundante Polpa Viva: 2 limas Além de que usamos sempre a lima de 21mm Não realizamos odontometria na odontopediatria

Relembrando o PQC

Modelagem e Sanificação (limpeza & desinfecção)

Modelagem: é a obtenção de um canal cirúrgico, realizado através da instrumentação, com instrumentos manuais e rotatórios, que apresente conicidade, paredes divergentes para oclusal ou incisal e lisas, que contenha em toda sua extensão o canal anatômico, de modo a não alterar a forma original do canal radicular e que mantenha o forame apical, também na sua posição original.

Sanificação: é composta pela ação conjugada de substâncias químicas auxiliares da instrumentação e instrumentos endodônticos, com vistas à promoção da limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares.

Limpeza: consiste na eliminação de irritantes como os subprodutos de microrganismos e tecido pulpar vivo ou mortificado e outro qualquer componente orgânico ou inorgânico, presente no interior do canal.

Desinfecção: consiste na eliminação de agentes patogênicos

Endo PTC: Tween 80, Peróxido de Uréia e Carbowax, associado ao Hipoclorito de Sódio (NaOCL) na concentração de 1,0%, promove uma reação de efervescência continuada com a liberação de oxigênio, que favorece a instrumentação, atuando como agente lubrificante, antimicrobiano, solvente de matéria orgânica,

desodorizante, clareador e detergente por promover a saponificação de lipídios.

EDTA-T: o EDTA-T a 17% é o ácido etilenodiamino tetracético que apresenta propriedades como: ação descalcificante, capacidade de remoção de matéria inorgânica, aumento da permeabilidade dentinária, abertura dos túbulos dentinários, além da associação do tergentol na solução (tensoativo aniônico).

Sua utilização se dá como irrigação final (no mínimo 5ml), na remoção da matéria inorgânica e abertura de túbulos removendo a camada residual ("smear layer").

Irrigantes: 1. *Hipoclorito de Sódio a 1%* Alta capacidade de dissolver material orgânico e efeito antimicrobiano frente a micro-organismos resistentes como o *Enterococos faecalis* e *Candida albicans* Utilizar de 04 a 5 ml de

irrigação.

OU

2. *Clorexidina a 2% gel* Solução biocompatível, atividade antimicrobiana de amplo espectro, Incluindo fungos, tem sua ação aumentada devido à sua propriedade de substantividade, que pode perdurar de 48 horas a 12 semanas. Não tem atividade solvente sobre os tecidos orgânicos.

O processo de limpeza chega ao fim quando, após o último instrumento, as substâncias químicas mostram-se brancas e límpidas.

Fechamento dos condutos

Procede-se à irrigação e aspiração final com EDTA-T na porção mais apical dos canais.

Procede-se secagem dos canais com o uso de sugador e pontas de aspiração de médio e pequeno calibre, completando com o uso de papel absorvente (cone estéril).

A obturação dos canais se da pela pasta reabsorvível (Guedes-Pinto).

Obtura-se o canal com a pasta reabsorvível (placa de vidro despolida) levada aos condutos com auxilio de uma lima tipo Kerr.

Sobre a pasta acomoda-se e veda-se a câmara pulpar com uma camada de guta-percha.

Sobre a guta percha realiza-se a restauração provisória.

A **pasta obturadora Guedes Pinto PREPARO**: 1cm de um tubete de anestésico com Iodofórmio, 1 cm de Rifocort e 2 gotas de paramonoclorofenol canforado. A pasta será manipulada em uma placa de vidro tendo seus componentes associados até a completa homogeneização.

Outro tipo de pasta é a **base de iodofórmio Feapex**, contendo iodofórmio, HC e óleo de silicone. **Vantagens** desta pasta: menos irritante e mais biocompatível e regenerador das lesões apicais.

O acompanhamento **clínico e radiográfico** é fundamental nas terapias pulpares em dentes decíduos 1 mês = → 3 meses → 6 meses → 12 meses

Qual a importância do Selamento Coronário?

Impedir a infiltração bacteriana e recontaminação do sistema de canais radiculares

CIV e o Bioplic são materiais que apresentam os melhores resultados como selador temporário

ANOTAÇÕES

13

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 13)

PONTOS-CHAVE

Restaurações definitivas devem ser realizadas o mais rápido possível para não comprometer o sucesso da terapia endodôntica.

Exodontia em

Odontopediatria

Indicações

Grandes destruições coronárias sendo impossível de realizar um tratamento restaurador.
Retenção prolongada.
Rarefação óssea persistente.
Fraturas.
Bifurcação comprometida.
2/3 de rizólise e *comprometimento pulpar*. Tem que estar comprometido para ser indicação de exodontia.
Indicação de ortodontia.
Rompimento da cripta do germe do permanente.
Alveolise.
Anquilose.

Princípios:

Necessidade Cirúrgica (preciso fazer)
Oportunidade Cirúrgica (analisar o contexto)

Contra indicação absoluta: Neoplasia *Contra indicação que não é absoluta (ou seja, vou ter que adiar): questões sistêmicas.*

Exemplo: Supranumerário Temos que avaliar a necessidade de remoção e qual o momento certo. Avaliar condições e questões psicológicas, avaliar o tempo que vou precisar que a criança fique na cadeira. *Necessidade: tenho que remover/ Oportunidade: a forma como vou realizar a cirurgia, questões psicológicas,*

questões de urgência, posição do permanente, crescimento da maxila. Lembrando que podemos ter uma reabsorção patológica do decíduo, podendo até mesmo ser criado um cisto → reabsorção óssea. Ou seja, terá situações que vou ter que fazer a remoção, outros posso aguardar.

Casos clínicos em cirurgia pediátrica

Caso 1:

Paciente sexo masculino, 04 anos de idade. Indicação de exodontia dos elementos: 51, 61, 52, 62. Descreva o protocolo de atendimento.



Imagem ilustrativa

Vemos uma grande destruição coronária.

1. Anamnese 2. Exames complementares (periapical anterior modificada) 3. Consulta de condicionamento para exodontia 4. Anestésico tópico 5. Bloqueios / infiltrativa / Intraligamentar / transpapilar. Primeiro vamos fazer 51 e 52 e depois 61 e 62 Sempre com agulha curta e extra curta em pediatria 6. Descolamento (descolador de Molt ou o Hollenback)

7. Alavanca com movimentos de Cunha (caso haja necessidade) 8. Fórceps Usamos os mesmos em crianças Não fazemos curetagem devido ao germe do permanente. 9. Sutura? *Tudo depende da quantidade de raiz. Se o alvéolo for muito grande, iremos suturar. Caso seja pequeno, Não realizo a sutura pois posso pegar o germe dentário.*

Cuidados P.O:

Analgésicos;

Evitar alimentos quentes e cítricos. Por 48hrs em crianças.

Caso 2:



Caso de retenção prolongada.

Paciente sexo feminino, 06 anos de idade. Queixa principal: "Dente não cai"

Descreva seu protocolo de atendimento.

1. Anamnese 2. Periapical 3. Anestésico tópico 4. Infiltrativa / transpapilar e complementos na lingual

Na Ped usamos lidocaína ou mepivacaína 5. Descolamento

Temos que pensar que é uma coroa menor, então na maioria das vezes faço a luxação com o molt ou hollenback
6. Caso tenha necessidade usar o fórceps 7. Sutura ??

*mesmas considerações que o quadro acima.

Caso 3:

Caso de rarefação óssea persistente.

Paciente sexo masculino, 06 anos de idade. Queixa principal: Dor e Inchaço

Descreva seu protocolo de atendimento.

1. Anestesia Pterigomandibular (por ser molar) 2. Descolamento 3. Luxação com o molt ou hollenback 4. Alavanca (caso haja necessidade) 5. Fórceps (caso haja necessidade) 6. Não realizamos curetagem 7. Sutura

*mesmas considerações que o quadro acima.

Caso 4:

Caso de bifurcação comprometida

Paciente sexo masculino, 06 anos de idade. Queixa principal: dor e inchaço.

Descreva seu protocolo de atendimento.

1. Periapical / panorâmica 2. Anestésico tópico 3. Ptergomandibular + infiltrativa 4. Descolamento 5. Luxação com o molt ou hollenck 6. Fórceps

7. Se precisamos, odontosecção e clivagem 8. Sutura 9. Mantenedor de espaço

Caso 5:

Caso de anquilose.

Paciente sexo masculino, 10 anos de idade. Encaminhado para exodontia do elemento 85.

Descreva seu protocolo de atendimento.

Anquilose = deixa de existir o ligamento periodontal. O dente “grudou” no osso, ou seja, vamos ter que realizar osteotomia e odontosecção. Lembrando sempre do germe permanente. Estamos em infraoclusão devido a anquilose. Ausência de raiz. Teve uma “briga” entre o dente decíduo e o permanente. O permanente tentou sair e o decíduo não conseguia sair. Então parou o processo de erupção.

Outros exemplos em que realizamos a exodontia:

2/3 de rizólise e comprometimento pulpar;
Indicação ortodôntica;
Rompimento da cripta do germe do permanente;
Alveólise;

Sucesso na exodontia de decíduos

Biossegurança;
Organização da mesa cirúrgica;
Condicionamento do paciente *Decíduo — sucessor do permanente — dor e diferente*

pressão. Não é para a criança sentir dor; Desviar a atenção da criança;

Técnica anestésica correta *Sempre testar a anestesia.*
Segurança e firmeza profissional.

Técnicas de exodontia

Em dentes anteriores

As raízes são arredondadas, fazemos o movimento de rotação.

Nos dentes decíduos usamos os mesmos fórceps para adulto.

Em relação as alavancas podemos usar as retas.

Anestesia tópica: Seca a mucosa → rolete de algodão / cotonete na área que vai realizar a punção → aguardar 3 minutos com a boca aberta.

NUNCA fazer anestesia por palatina, fazer intrapapilar toda volta do dente e transpapilar para anestesiá-lo pelo palato vestibular.

Após a anestesia fazemos a **sindesmotomia**, pode ser com um Hollenback 3s.

Após usamos as alavancas e o fórceps, para realizar a **apreensão e extrusão**.

Para conter o sangramento, umedece a gaze com anestésico com vaso, assim conseguimos visualizar melhor a área.

Realizar quantas suturas forem necessárias. Não realizar sutura quando não é uma extração precoce.

NÃO realizamos curetagem!.

ANOTAÇÕES

14

AULA - TEÓRICO

Odontopediatria Teórico (parte 14)

Em dentes posteriores

Dificuldades

PONTOS-CHAVE

- Tem uma maior retenção mecânica
- Presença de cárie extensa
- Divergência de raízes
- Presença do germe do permanente

O mesmo passo a passo dos dentes anteriores.

Não fazemos movimentos rotatórios, porque pode quebrar.

Em algumas situações é necessário realizar a odontosseção.

Cuidados

- Pressão é diferente de dor
- Fórceps — do bordo gengival
- Apreensão firme
- Deslocamento lento e gradual
- Não curetar
- Suturar sempre que possível.

Acidentes

- Deslocamento ou avulsão do germe
- Fratura radicular

Orientações pós-operatórias

- As mesmas do paciente adulto
- Lembrar os responsáveis da anestesia
- Úlcera traumática — devido a criança poder se morder devido a anestesia

ANOTAÇÕES

Odontopediatria Clínica

Aula - Clínica

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Odontopediatria Clínica	3
02 Odontopediatria Clínica (parte 2)	7
03 Odontopediatria Clínica (parte 3)	13

01

AULA - CLÍNICA

Odontopediatria Clínica

Aula ministrada pelo Dr. Prof. Ms. Gerson Lopes, na Universidade Cidade de São Paulo. Utilizei o livro de Odontopediatria do Antônio Carlos Guedes-Pinto.

Instrumentos para determinar o risco: Diário alimentar, índice de placa, índice de sangramento, exames clínicos e complementares → COM ISSO FAREI O PLANEJAMENTO.

Traumatismo Dentário

Trauma = urgência

Epidemiologia

PONTOS-CHAVE

Qual o **gênero** da criança? O gênero masculino na epidemiologia é o que mais se acidenta.

Qual o **dente**? Normalmente os mais afetados é os IC superiores. O trauma é como se eu jogasse um tijolo no piano. Trauma é um jogo de xadrez, não podemos se antecipar por nada.

Qual o **arco**? A maioria é o arco superior.

A sua **etiologia** Podemos ter casos sucessivos.

O local

Injúria traumática

Prevenção

Ortodontia, porque as vezes as crianças possui os ICS mais vestibularizados.

Tratamento das maloclusões.

Proteção nos esportes.

Segurança nos ambientes.

Segurança nos meios de locomoção (bicicleta as vezes) .

Informações a responsáveis e professores → para caso tenha alguma queda mais seria, eles pode fazer alguns procedimento, como: ir a um atendimento especializado.

Exame do paciente traumatizado

Exame geral

Anamnese

Exame físico extra-oral

Exame físico Intra-oral

Exame radiográfico com data Não existe uma correlação entre uma "batidona" e uma "batidinha".

Anamnese direcionada ao trauma

Como?

Onde?

Quando?

1. Higienização da região com solução fisiológica e clorexidina com o auxílio de gazes e cotonete.

Exame do paciente traumatizado

Exame físico extra-oral Tecidos moles, ossos, ATM

Exame físico intra-oral Tecidos moles, ossos, ATM

Exame radiográfico

Radiografia periapical modificada normalmente para a região anterior. Filme radiográfico de adulto posicionado em horizontal para pegar a região de canino a canino, usando normalmente a técnica da bisettriz.

Temos que sempre lembrar da idade do paciente. E a idade recomendada para fazer este exame é 5/6 anos, porque é a região ântero superior acontece muitas alterações de forma e número e podemos identificar com a periapical modificada.

Nos exames radiográficos podemos observar alguns traumas que afetaram o ápice do dente decíduo, nesta hora precisamos nos perguntar: A cripta rompeu? Se sim, exo. Se não, terapia pulpar. Porém se rompeu a cripta e o CD e o responsável optar por não realizar a exo, temos que estar cientes que o meio da lesão é ácido, e pode “dissolver” o dente permanente.

Preocupações frente ao traumatismo na dentição decídua

Conseguimos observar na palatina dos dentes e normalmente está mais escuro. Se está escuro as vezes preciso tratar e as vezes não, porque pode ser um “sangue pisado” e tende voltar a coloração normal, mas temos o inverso, pode necrosar a polpa. Pode correr danos ao dente permanente, uma má formação.

Nós precisamos entender que o trauma tem uma grande relação entre o dente decíduo e o permanente. Podendo ter até mesmo um deslocamento do dente permanente.

Importância da higiene caseira no paciente com traumatismo dentário

Temos que orientar pois é fundamental para não ter alguma contaminação. Crianças que consegue fazer gargarejo com algum enxaguante bucal sem álcool com antisséptico, ou até mesmo uma gaze umedecida.

Orientações pós trauma

1. **Repouso do dente:** dieta líquido-pastosa, remoção de hábitos de sucção (como o dedo e a chupeta). 2. Higiene local. 3. Avaliar a necessidade de antitetânica e terapêutica medicamentosa. 4. **Necessidade do controle-clínico radiográfico:** sequelas nos dentes decíduos e acompanhamento do desenvolvimento do sucessor permanente.

Diferenças no tratamento do traumatismo de dentes decíduos e permanentes

1. **Ciclo biológico curto:** resposta limitada frente a agressões. 2. **Risco de afetar o germe do sucessor em desenvolvimento:** quanto menor o Estágio de Nolla, maior a chance de ser afetado. 3. **Atendimento adequado:** idade e cooperação/ contenção física ou condicionamento psicológico.

Classificação dos traumatismos dentários

Tecidos duros dos dentes

Trinca de esmalte Identificamos através do fotopolimerizador.

Fratura de esmalte

Fratura de esmalte e dentina **sem** exposição pulpar É ótimo usarmos as coroas ableh para restaurar.

Fratura de esmalte e dentina **com** exposição pulpar

Fratura coronoradicular

Fratura radicular: terço cervical / médio / apical.

Para cada tipo de fratura eu tenho um tratamento, e o dente pode sofrer um trauma no tecido duro ou mole.

As fraturas de tecido duro acontecem mais em dentes permanentes ou decíduos? Acontecem mais em dentes decíduos devido a densidade óssea.

Estruturas de suporte

Tecidos moles: laceração - abrasão - contusão

Concussão → não teve alteração visualmente, mas teve trauma

Subluxação

Luxação lateral: mesial - distal - vestibular - palatina

Luxação intrusiva

Luxação extrusiva

Avulsão ou deslocamento total

Fraturas ósseas

Laceração

Ferimento raso/profundo: objeto cortante;

Pode ser necessário sutura (tamanho)

Limpeza e profilaxia: se houver contaminação.

Antibioticoterapia ou antitetânica.

Abrasão

Lesão superficial: raspagem na mucosa. "É um ralado".

Tratamento: limpeza e profilaxia.



Contusão

É um impacto.

Impacto com objetivo sem corte causando hemorragia submucosa (equimose)

Não requer tratamento.

Concussão

Repouso oclusal.

Orientação de higiene.

Acompanhamento clínico-radiográfico.

É só uma “batidinha”.

Essa “batidinha” “besta”, no futuro, pode deixar o dente mais escuro. Esse escuro pode indicar uma necrose pulpar.

Subluxação

OBS: a “batidinha” que tem sangue presente no local, é um sinal de deslocamento periodontal. Isso porque teve deslocamento.

Fazemos uma contenção semi-rígida na vestibular. Faz um acompanhamento de 7 a 15 dias, e depois remove essa contenção. Fazemos com um fio de nylon, ou até mesmo com o fiozinho que vem dentro do sugador. Não fazemos na palatina para não ter alteração na mordida/oclusão do paciente. É para manter no local, não realizar movimentações.

Como fazemos a contenção? Fio de nylon + Resina composta ou flor nas faces vestibulares. Se *houver* mobilidade.



ANOTAÇÕES

02

AULA - CLÍNICA

Odontopediatria Clínica (parte 2)

Luxação lateral:

Mesial / Distal / Vestibular / Palatina

Avalia o intervalo de tempo entre acidente e atendimento → tratamento imediato X tratamento mediato (tardio).

Se tiver interferência oclusal, não espera o dente reposicionar, se tiver você espera 7 dias → é a consequência de algum deslocamento. As vezes ele volta sozinho (quando não tiver interferência oclusal).

Nos dentes anteriores, para ocorrer anquilose, sempre está relacionado com trauma. Para isso tem que ter um controle radiográfico, pode ser feito de 15 em 15 dias, mensalmente. Assim vamos observando a criança juntamente com a mãe, e dar alta. Normalmente atrasa a erupção do outro dente. *Os dentes mais comuns de dar anquilose é os molares inferiores, por conta da sequência de erupção.*

Tratamento Imediato

PONTOS-CHAVE

Redução

Contenção

Acompanhamento clínico-radiográfico

Tratamento Tardio 1) Com interferência oclusal

Exodontia

Mantenedor de espaço 2) Sem interferência oclusal

Aguardar o reposicionamento

Degeneração Cálctica: quando ocorre um trauma, e depois de alguns longos meses, a polpa do dente decíduo fica “retida”. É um achado radiográfico, pois não fazemos nada, só acompanhamos.



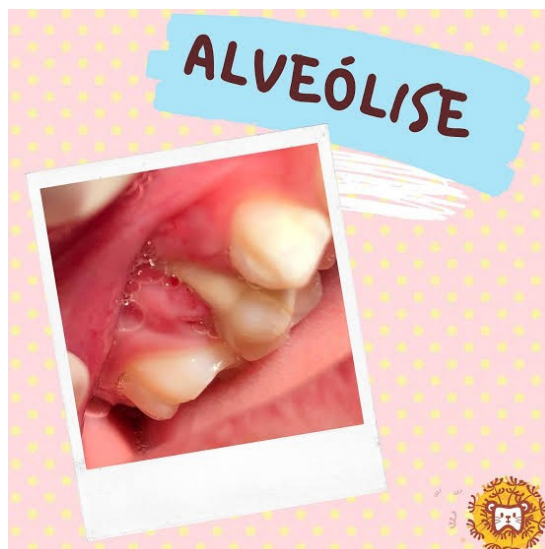
FIGURA 1 - No incisivo central direito a Metamorfose Cálcica da Polpa caracteriza-se pela obliteração da câmara pulpar e estreitamento do canal radicular com apagamento dos seus limites pulpaes. No incisivo central esquerdo a câmara pulpar e canal radicular estão com seus limites preservados, mas nota-se lesão periapical crônica, indicando necrose pulpar asséptica. Ambas as situações indicam história anterior de traumatismo dentário, reforçada pelas fraturas coronárias e relato de acidente por parte do paciente.

Apenas um exemplo, para entender o que é degeneração cálcica

Luxação intrusiva



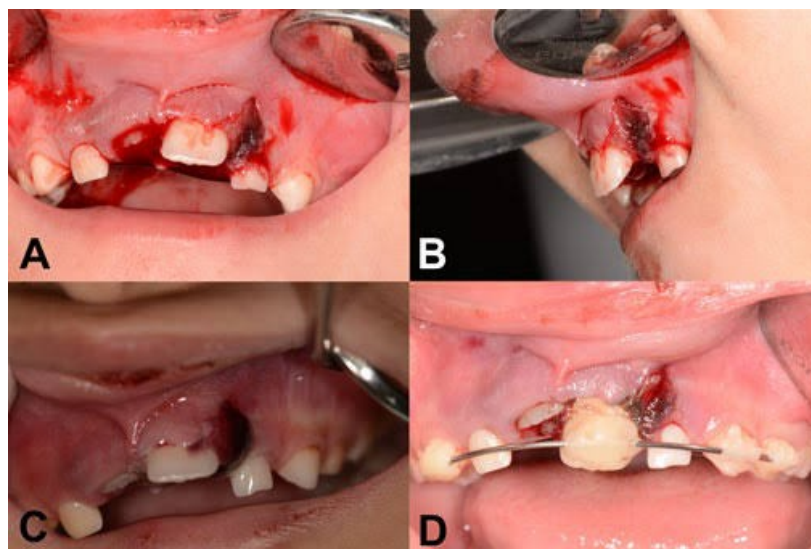
Aguardar a reerupção por até 4 meses.
Se não reerupcionam fazemos exodontia.
Não tracionar o dente decíduo.



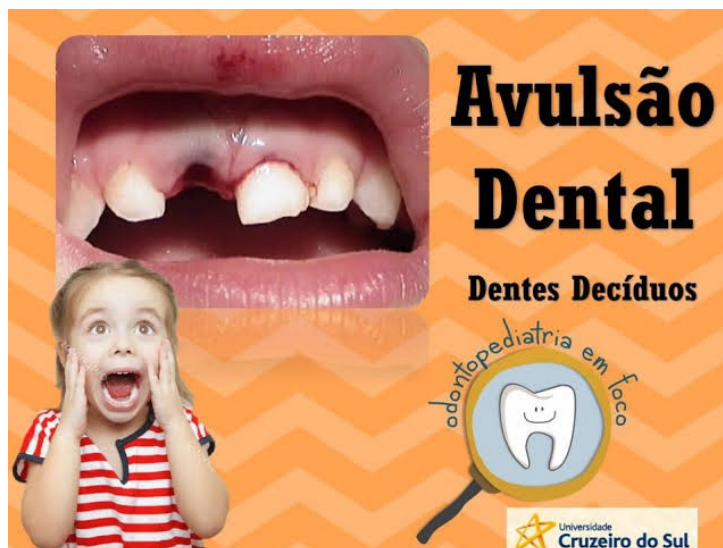
OBS: se a raiz começa a se exteriorizar fazemos a exodontia, pois ocorreu a **ALVEÓLISE** (é uma patologia ósseo-gengival caracterizada pela exposição da raiz dentária a cavidade oral, em função da reabsorção da tábua óssea alveolar).

Luxação extrusiva

O dente sai parcialmente do alvéolo.



Avulsão ou deslocamento total



Podemos executar um aparelho ortopédico com um dente decíduo (uma prótese).

Sequelas e reações dos traumatismos para dentição decídua

Observadas durante o acompanhamento clínico-radiográfico.

Alterações clínicas:

- Alteração de cor da coroa
- Mobilidade
- Fístula
- Anquilose
- Retenção prolongada causada pela anquilose.*
- Edema

Alterações radiográficas:

- Presença de lesão periapical
- Rompimento da cripta permanente
- Ausência do espaço pericementário (anquilose)
- Obliteração da câmara ou canal pulpar
- Reabsorção radicular externa
- Reabsorção radicular interna (amplia o conduto radicular)

Alteração de cor da coroa:

- Avermelhada
- Amarelada
- Acinzentada

Elas dão uma diretriz de como esta a polpa.

COR AVERMELHADA: hiperemia pulpar.

COR CINZENTADA: necrose pulpar.

COR AMARELADA: degeneração cálcica.

É possível que também vejamos uma **fístula**. E nem sempre é indicação de exodontia, tudo depende da condição, sequência de erupção e os estágios de Nolla. Mas normalmente é terapia pulpar.



Reabsorção radicular externa

- Inflamatória
- Substitutiva
- De superfície

Repercussão das injúrias traumáticas nos dentes decíduos para o dente permanente

- Descoloração branca à amarelo amarronzado
- Descoloração branca à amarelo amarronzado e hipoplasia circular de esmalte
- Dilaceração da coroa
- Má formação (odontoma)
- Duplicação radicular
- Angulação radicular vestibular
- Angulação à dilaceração radicular lateral
- Sequestro do germe do permanente
- Alteração de erupção (paralisa a rizogênese)

Técnicas de Gestão de Comportamento em Odontopediatria

É um conjunto particular de habilidades.

A Odontopediatria é uma especialidade que engloba todas as habilidades técnicas da odontologia, diante de um cenário fisiológico de compreensão do desenvolvimento infantil, na saúde e na doença.

A maior diferença que existe entre o tratamento de crianças e adultos. É que para os adultos é a relação de um para um. Já as crianças, usamos uma linguagem diferente, é a relação de dois pra um (o CD, o paciente infantil e seus pais/responsáveis).

Vantagens de conhecer e usar as técnicas de manejo de comportamento

- Construir uma relação de confiança com a criança;
- Educar o paciente;
- Prevenir e aliviar o medo e a ansiedade odontológica da criança.

Técnicas não farmacológicas

- Abordagem via comunicação verbal, não verbal (*expressão facial, comportamento, a criação fica escondida atrás da mãe, não olha nos olhos*) e ambas.
- A comunicação é subjetiva:
- Extensão da personalidade
- Habilidade do cirurgião-dentista.

Técnicas

1. Falar-mostrar-fazer 2. Reforço positivo 3. Distração 4. Comunicação não verbal 5. Controle pela voz 6. Estabilização protetora

Usamos todas ao mesmo tempo, algumas mais reforçadas que outras.

Falar-Mostrar-Fazer

- Antiga DMF:** diga-mostre-faça.
- Muito boa para iniciar o tratamento odontológico.
- Explicar o procedimento ao paciente (*falar*).
- Demonstrar seus aspectos visuais, auditivo e olfativo (*mostrar*).
- Realizá-lo (*fazer*).

“Usar vocabulário adequado” / “gradual”

Auxiliares / Higienistas / Dentistas ➡ Demonstrar os vários instrumentos, passo a passo, antes de usá-los, dizendo,

ANOTAÇÕES

03

AULA - CLÍNICA

Odontopediatria Clínica (parte 3)

mostrando e fazendo → Somente quando a criança tem a visão dos procedimentos, é que a sucessivas aproximações podem ser realizadas.

Reforço positivo

"Recompensa o paciente por comportamentos desejáveis e reforça a recorrência destes comportamentos".

Pode ser:

A) Social: expressão facial de alegria, demonstração de afeto, elogios. **B) Não social:** prêmios, brinquedos.

Distração

Técnica para desviar a atenção da criança dos procedimentos desagradáveis por meio da diversão.

PONTOS-CHAVE

Brinquedos coloridos, livros (adequados), conversas que envolvem a criança, vídeos...

"Nossa Maria, a boneca tem um laço no cabelo.."

MODELAGEM

É a exposição do paciente à um (ou mais indivíduos) que demonstrem comportamento adequado. O paciente irá imitar o modelo observado quando vivenciar experiências similares. Como por exemplo: quando vem os irmãos juntos e a mãe diz: "Olha seu irmão como é mais corajoso, mais forte".

Pode ser:

1. Real, presente — ao vivo; 2. Filme — simbólico;

Quanto mais próxima a idade, melhor.

Comunicação Não Verbal

Reforça e guia o comportamento através do contato, postura e expressão facial.

Aumenta o senso de controle da criança.

Objetivos:

1. Melhorar a eficiência de outras técnicas de outras abordagens. 2. Obter e manter a atenção do paciente e acompanhante.

Utilizam-se mudanças do corpo:

Timbre das cordas vocais
Respiração
Gestos manuais
Contato dos olhos

Processos que acontecem em sincronia natural com os aspectos verbais.

São eficazes quando pensamentos e sentimentos do profissional contribuem para isso...

Sorriso
Simpatia
Amabilidade

Entendimento

Toque (sutil):

Excelente estratégia para reduzir o medo.

Toque das mãos
Carinho
Cuidados
Proteção dos braços
Abraço

A criança se sente aceita e amada.

A empatia do profissional no contexto da inter-relação, percepção das necessidades dos pais e da criança...

Controle pela voz

“É uma alteração controlada do volume e tom da voz que influencia e direciona o comportamento do paciente”.

Com o tom da voz podemos colocar limites quando ocorrer um comportamento inadequado! Desvia a atenção da criança de sua conduta inadequada e a chama para interagir com o profissional além de demonstrar autoridade.

É necessário um contato visual, expressão facial e postura.

Expressão facial de confiança;
“Quem manda aqui sou eu”
“Ummm, dois, três, e no três eu não quero ouvir mais nenhum choro”.

A atitude ou expectativas do dentista podem afetar o resultado da consulta.

Êxito no tratamento:

Afirmações positivas;
Equipe ciente de seus papéis — a criança só escuta um de cada vez.

Não devemos:

Realizar perguntas ou comentários descuidados.

Estabilização protetora

“Métodos utilizados com o objetivo de manter o paciente na cadeira odontológica em condições favoráveis para a execução do atendimento”.

1. Pode ser física ou química 2. É feita pelo profissional e/ou pelos auxiliares (estabilização ativa). 3. Pode ser realizada também através de acessórios para imobilizar o indivíduo (estabilização passiva).

Acessórios:

Cintas
Faixas
Lençóis
Pacotes pediátricos (estabilização passiva).

MÃO SOBRE A BOCA HAND OVER MOUTH EXERCISE (HOME)

Contra-indicações: crianças incapacitadas, imaturas e sob medicação cuja compreensão às ordens do dentista, se encontra comprometida.

Último recurso (crianças altamente antagonistas).

Obtém a atenção da criança e silêncio para ele escutar o dentista.

Colocar a criança firmemente na cadeira odontológica; Contenção para sua proteção e da equipe; Dentista posiciona a mão sobre a boca da criança para abafar o ruído, e simultaneamente se aproxima do ouvido e diz baixo, sem gritar, calmamente e sem raiva “você tem que parar de gritar, quero conversar com você, quero olhar os seus dentes”. A criança interrompe os gritos e o dentista remove a mão. Imediatamente reforça o comportamento da criança com um elogio: “sabia que você era capaz de colaborar” ou “gosto de você porque você é um bom ajudante”.

Indicações:

Crianças acima de 4 anos, saudáveis, madura o suficiente para compreender as direções do dentista e cooperar com as expectativas da consulta, mas que chega ao consultório gritando, agressiva e histérica, apresentando um

comportamento hostil e desregrado ao tratamento dental.

Método usado para:

Controlar birras e outros ataques de ira.

Deve ser usado com o controle de voz.

A criança deva ser avaliada em seu grau de inteligência e capacidade de entendimento.

É indispensável que se preste atenção à opinião dos pais.

ANOTAÇÕES